BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Quy trình kỹ thuật điều dưỡng hồi sức cấp cứu

Bản rà soát năm 2026 theo đề cương QĐ 3023/QĐ-BYT

BẢN TRÌNH THẨM ĐỊNH — CHƯA BAN HÀNH

Rà soát từ QTKT HSCC 2025.docx do Phòng Điều dưỡng cung cấp. Giữ danh mục 26 quy trình và nội dung nền phù hợp; chuẩn hóa các mục chuẩn bị, sửa các hướng dẫn chưa an toàn và bổ sung theo dõi. Áp dụng cho người lớn, nhân viên đã được đào tạo, trong phạm vi hành nghề, phân công và danh mục kỹ thuật của bệnh viện.

Các quy trình trẻ em, sơ sinh; đặt hoặc thay đường thở khó; thủ thuật can thiệp ngoài nội dung chăm sóc cần tài liệu riêng. Y lệnh, phác đồ cấp cứu và hướng dẫn sử dụng đúng model thiết bị phải được đối chiếu khi triển khai. Bản này không tự xác lập quyền thực hiện kỹ thuật hoặc ngày có hiệu lực.

Thông tin quản lý	Nội dung xác nhận
Phiên bản dự thảo	1.0 — ngày rà soát 13/10/2026
Người biên soạn và thẩm định	……
Người phê duyệt	……
Số quyết định và ngày hiệu lực	……
Mã quy trình	Bệnh viện cấp theo hệ thống quản lý tài liệu

Các nội dung cần xác nhận trước ban hành

Hội đồng chuyên môn xác nhận phạm vi người lớn, nhân sự thực hiện và chỉ định; Phòng Điều dưỡng phối hợp bác sĩ chuyên khoa đối chiếu chi tiết với tài liệu chuyên ngành tương ứng. Các tần suất đề xuất, mục tiêu oxy và cuff, xử trí dịch tồn dư phải được cá thể hóa và đưa vào quy định nội bộ được duyệt.

Bộ phận thiết bị y tế xác nhận model máy thở, monitor, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, bộ khí dung và catheter. Bệnh viện bổ sung hoặc đính kèm hướng dẫn thao tác theo đúng model, loại vật tư, khử khuẩn và bảo trì; các quy trình vận hành chung không thay thế tài liệu nhà sản xuất.

Đã sửa dẫn chiếu QĐ 3023/2023/QĐ-BYT thành QĐ 3023/QĐ-BYT và Thông tư 23/2004/TT-BYT ghi ngày năm 2024 thành Thông tư 23/2024/TT-BYT. QĐ 3023 dùng để chuẩn hóa đề cương; các số tham khảo trong ngoặc vuông dẫn đến danh mục cuối tài liệu.

Hai mục hút kín số 08 và 13 trong bản nguồn cùng phạm vi chăm sóc NKQ hoặc MKQ: giữ hai vị trí để đối chiếu, dùng cùng nội dung đã thống nhất. Khi ban hành, bệnh viện có thể gộp một mã để tránh hai bản song song; chưa tự loại bỏ mục của anh.

Nhóm	Thay đổi chính
Đường thở và oxy	Thống nhất đơn vị cuff; duy trì giữ ống khi đổi dây; hút tối đa 15 giây mỗi lượt, không bơm nước muối thường quy vào đường thở; phân biệt loại mặt nạ túi dự trữ.
Tiết niệu và catheter	Bơm bóng theo nhà sản xuất; theo dõi dịch rửa vào ra; lấy nước tiểu qua cổng; xử trí tắc, di lệch và nhiễm khuẩn có đánh giá bác sĩ.
Dinh dưỡng và chăm sóc	Xác nhận vị trí ống; bỏ ngưỡng tồn dư 100 hoặc 200 ml áp dụng máy móc; giảm nguy cơ hít sặc và tì đè.
Thiết bị và huyết động	Không áp dụng nút bấm của một model cho mọi máy; kiểm tra thuốc nguy cơ cao; không ngắt máy thở hoặc trừ PEEP tùy ý khi đo CVP.

Danh mục quy trình

01. THỞ OXY QUA GỌNG KÍNH

02. KHÍ DUNG THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN

03. RỬA BÀNG QUANG

04. RỬA BÀNG QUANG LẤY MÁU CỤC

05. THỞ OXY QUA MẶT NẠ CÓ TÚI

06. CHĂM SÓC CANUYN MỞ KHÍ QUẢN

07. CHĂM SÓC ỐNG NỘI KHÍ QUẢN

08. HÚT ĐỜM ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI BẰNG HỆ THỐNG HÚT KÍN

09. VỖ RUNG LỒNG NGỰC Ở NGƯỜI BỆNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

10. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

11. ĐO ÁP LỰC CỦA BÓNG CHÈN Ở NGƯỜI BỆNH ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN HOẶC MỞ KHÍ QUẢN

12. KHÍ DUNG CHO NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

13. HÚT ĐỜM CHO NGƯỜI BỆNH CÓ ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN VÀ MỞ KHÍ QUẢN BẰNG ỐNG HÚT ĐỜM KÍN

14. CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM

15. ĐẶT CATHETER NGOẠI VI

16. LẤY NƯỚC TIỂU LÀM XÉT NGHIỆM NGƯỜI BỆNH CÓ ỐNG THÔNG TIỂU

17. CHO ĂN QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY (Có kiểm tra thể tích dịch tồn dư)

18. CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG ĐẶC BIỆT

19. GỘI ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

20. THỬ ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH

21. TRUYỀN THUỐC BẰNG BƠM TIÊM ĐIỆN

22. TRUYỀN DỊCH BẰNG MÁY TRUYỀN DỊCH

23. SỬ DỤNG MÁY MONITOR

24. ĐO ĐIỆN TÂM ĐỒ 12 CHUYỂN ĐẠO TẠI CHỖ

25. HÚT ĐỜM CHO NGƯỜI BỆNH CÓ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN, MỞ KHÍ QUẢN

26. ĐO ÁP LỰC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM BẰNG CỘT NƯỚC (THƯỚC ĐO ÁP LỰC)

01 THỞ OXY QUA GỌNG KÍNH

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Thở oxy qua gọng kính bổ sung oxy cho người bệnh còn tự thở. Hiệu quả phụ thuộc lưu lượng, kiểu thở và mức độ thông thoáng đường thở; dụng cụ này không thay thế hỗ trợ thông khí khi cần.

2. CHỈ ĐỊNH

Giảm oxy máu hoặc cần bổ sung oxy theo đánh giá lâm sàng và chỉ định của bác sĩ. Đặt mục tiêu SpO2 phù hợp; không chỉ định oxy thường quy chỉ vì có bệnh tim phổi nếu không có nhu cầu bổ sung oxy.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không có chống chỉ định tuyệt đối.

- Chống chỉ định tương đối:

+ Hẹp hoặc tắc mũi do chất nhầy.

+ Polype trong mũi.

4. THẬN TRỌNG

Theo dõi nguy cơ tăng CO2, giảm thông khí và tổn thương da niêm mạc. Mục tiêu tham khảo ở người lớn: SpO2 94–98%; người có nguy cơ suy hô hấp tăng CO2 thường 88–92% trong khi chờ đánh giá khí máu. Bác sĩ cá thể hóa mục tiêu [5].

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng.

5.2. Thuốc

Oxy y tế theo mục tiêu và chỉ định; không tự thêm thuốc.

5.3. Vật tư

Oxy gọng kính

5.4. Trang thiết bị

Nguồn oxy, lưu lượng kế, máy đo SpO2; hệ làm ẩm khi có chỉ định và tương thích.

5.5. Người bệnh

- người bệnh được giải thích các lợi ích, nguy cơ của thủ thuật. Động viên người bệnh hợp tác thở.

- Đảm bảo đường thở thông thoáng.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 05 phút - 10phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh người bệnh, kiểm tra chỉ định và mục tiêu SpO2; đánh giá ý thức, nhịp thở, SpO2, khả năng bảo vệ đường thở. Trong cấp cứu, thực hiện oxy và gọi hỗ trợ theo quy trình cấp cứu của bệnh viện.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay; kiểm tra nguồn oxy, lưu lượng kế, dây và gọng kính. Không bắt buộc làm ẩm cho mọi trường hợp oxy lưu lượng thấp; nếu dùng, thực hiện đúng hướng dẫn thiết bị và nước vô khuẩn phù hợp.

6.3. Bước 3: Chọn gọng kính đúng cỡ, đặt nhẹ vào mũi, cố định tránh tì đè. Điều chỉnh lưu lượng theo chỉ định, thông thường 1–6 lít/phút ở người lớn, trong giới hạn dụng cụ.

6.4. Bước 4: Đánh giá ngay đáp ứng và điều chỉnh để đạt mục tiêu. Nếu giảm oxy máu kéo dài, tăng công thở hoặc suy giảm ý thức, báo bác sĩ để đổi phương thức hỗ trợ.

6.5. Bước 5: Ghi loại dụng cụ, lưu lượng, mục tiêu và kết quả SpO2, diễn biến và người thực hiện.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi SpO2, nhịp thở, ý thức, mạch, huyết áp và khí máu khi có chỉ định; kiểm tra nguồn oxy và vị trí gọng kính.

Giảm thông khí hoặc tăng CO2: báo bác sĩ, điều chỉnh oxy theo mục tiêu và đánh giá hỗ trợ thông khí; không chỉ dựa vào SpO2 để kết luận thông khí đủ.

Khô niêm mạc, tì đè hoặc nhiễm bẩn dụng cụ: điều chỉnh chăm sóc da, thay dụng cụ theo chỉ định và quy định kiểm soát nhiễm khuẩn. Phòng cháy trong khu vực sử dụng oxy.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [5]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

02 KHÍ DUNG THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Khí dung thuốc giãn phế quản là đưa thuốc giãn phế quản dưới dạng sương mù, các hạt thuốc có kích thước 1-5 micromet vào khí phế quản để điều trị co thắt phế quản.

2. CHỈ ĐỊNH

Co thắt phế quản trong hen, COPD hoặc bệnh lý khác có chỉ định thuốc khí dung. Khó thở sau rút ống nội khí quản cần bác sĩ đánh giá nguyên nhân, không mặc định là co thắt phế quản.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với thuốc giãn phế quản.

4. THẬN TRỌNG

Thận trọng suy tim, rối loạn nhịp, nguy cơ hạ kali với thuốc kích thích beta và phản ứng nghịch thường. Budesonide là corticosteroid khí dung, không phải thuốc giãn phế quản; chỉ sử dụng khi có chỉ định riêng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

- 01 bác sĩ.

- 01 điều dưỡng.

5.2. Thuốc

- Thuốc để khí dung theo y lệnh: salbutamol, ipratropium, budesonide,…

5.3. Vật tư

Bộ khí dung: Dây

bầu và mặt nạ khí dung.

5.4. Trang thiết bị

Máy khí dung.

5.5. Người bệnh

- Được giải thích về kỹ thuật để hợp tác thực hiện.

- người bệnh tư thế thoải mái (tốt nhất ở tư thế ngồi).

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định khí dung với thuốc khí dung, liều lượng.

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

20-30 phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Buồng bệnh hoặc phòng thực hiện kỹ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, chỉ định, dị ứng, thuốc, liều, dung môi và loại thiết bị; đánh giá nhịp thở, SpO2 và mạch trước thực hiện.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, chuẩn bị và nạp thuốc đúng y lệnh; không tự phối hợp thuốc hoặc pha loãng khác hướng dẫn.

6.3. Bước 3: Cho người bệnh ngồi hoặc tư thế phù hợp; kết nối thiết bị, kiểm tra sương khí dung và đặt mặt nạ hoặc ống ngậm đúng cỡ.

6.4. Bước 4: Theo dõi trong suốt quá trình; thời gian theo liều và thiết bị, không cố định cho mọi thuốc. Dừng và báo bác sĩ nếu khó thở tăng, co thắt nghịch thường, loạn nhịp hoặc phản ứng dị ứng.

6.5. Bước 5: Kết thúc, chăm sóc miệng sau corticosteroid nếu sử dụng; xử lý bộ khí dung đúng hướng dẫn, ghi thuốc, liều, thời gian và đáp ứng.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

- Theo dõi tình trạng người bệnh trong quá trình khí dung để kịp thời phát hiện các bất thường. Những người bệnh nặng cần theo dõi các chỉ số trên máy theo dõi (mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2)…

- Khi người bệnh thấy khó chịu: Ngừng khí dung, đánh giá tình trạng người bệnh.

- Dị ứng: Khó thở, nổi mề đay, shock phản vệ, xử trí phác đồ dị ứng thuốc.

Ghi thời điểm, nhận định, thao tác, đáp ứng, tai biến và xử trí; báo và bàn giao bất thường cho bác sĩ, ca trực tiếp theo. Nếu có biến cố đe dọa tính mạng, gọi hỗ trợ và ưu tiên cấp cứu theo quy trình bệnh viện.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [14]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

03 RỬA BÀNG QUANG

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Rửa bàng quang là kỹ thuật nhằm làm sạch bàng quang bằng cách đưa một lượng dịch vô trùng vào bàng quang và sau đó dẫn lưu ra ngoài qua sonde bàng quang.

2. CHỈ ĐỊNH

Rửa bàng quang theo chỉ định tiết niệu khi có nguy cơ hoặc biểu hiện tắc do máu, cặn. Không rửa thường quy để phòng nhiễm khuẩn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nghi tổn thương niệu đạo, thủng bàng quang hoặc chưa xác định an toàn của đường dẫn lưu: không thực hiện cho đến khi bác sĩ tiết niệu đánh giá. Không bơm rửa qua catheter sai vị trí hoặc chưa xác nhận thông suốt.

4. THẬN TRỌNG

Phẫu thuật tiết niệu gần đây, bàng quang tổn thương, rối loạn đông máu, đau nhiều hoặc người bệnh không ổn định cần bác sĩ đánh giá trước. Duy trì hệ thống kín và thao tác áp lực thấp; không cố bơm khi gặp sức cản [7,8].

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng.

5.2. Thuốc

NaCl 0,9% vô khuẩn theo chỉ định; sát khuẩn phù hợp. Dịch và lượng bơm bóng theo hướng dẫn catheter, không mặc định 30 ml.

5.3. Vật tư

Sonde bàng quang.

Săng vô khuẩn loại có lỗ.

Săng vô khuẩn loại không có lỗ.

Gạc vô trùng.

Găng tay vô trùng.

Găng tay sạch.

Túi đựng nước tiểu.

Bộ dụng cụ thủ thuật.

Khẩu trang phẫu thuật.

Mũ phẫu thuật.

Quần áo vô khuẩn.

Bơm tiêm đầu nối catheter 50–60 ml khi rửa bằng tay; catheter thích hợp, catheter ba nhánh nếu rửa liên tục.

Gel bôi trơn vô khuẩn tan trong nước khi có chỉ định đặt catheter.

5.4. Trang thiết bị

Giường thủ thuật.

5.5. Người bệnh

Giải thích cho người bệnh lý do rửa bàng quang, quy trình rửa diễn ra như thế nào và biến chứng có thể xảy ra.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho người bệnh tiến hành làm thủ thuật.

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 20 phút - 30 phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, chỉ định, loại catheter, vị trí, độ thông và tình trạng người bệnh; giải thích, bảo đảm riêng tư, ghi sinh hiệu và đau trước thao tác.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn, dung dịch NaCl 0,9% theo chỉ định; ưu tiên hệ thống rửa kín thích hợp. Nếu cần đặt hoặc thay catheter, thực hiện theo quy trình thông tiểu riêng, không lấy độ sâu 10 cm làm quy tắc cho mọi người bệnh.

6.3. Bước 3: Chỉ bơm bóng sau khi xác nhận catheter đúng vị trí. Dùng loại dịch và thể tích ghi trên catheter hoặc hướng dẫn nhà sản xuất; không mặc định bóng 30 ml cho mọi trường hợp.

6.4. Bước 4: Kết nối đúng nhánh rửa, dẫn lưu và bóng chèn. Khi lấy máu cục bằng tay, sử dụng bơm tiêm đầu nối catheter 50–60 ml phù hợp, bơm và hút nhẹ theo chỉ định, không tạo áp lực cưỡng bức.

6.5. Bước 5: Rửa liên tục khi có y lệnh: dùng catheter ba nhánh và hệ thống kín; điều chỉnh theo màu dịch ra, mức chảy máu và độ thông. Theo dõi liên tục dòng ra, không để dịch vào khi đường ra tắc.

6.6. Bước 6: Kết thúc hoặc chuyển sang rửa liên tục theo bác sĩ; cố định catheter, giữ túi thấp hơn bàng quang, ghi lượng dịch vào và tổng dịch ra, màu sắc, máu cục và đáp ứng.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi đau, căng bàng quang, dòng chảy, màu dịch và sinh hiệu. Nước tiểu thực = tổng dịch dẫn lưu ra trừ tổng dịch rửa vào trong cùng khoảng thời gian; ghi riêng hai lượng để đánh giá cân bằng.

Dòng ra giảm hoặc ngừng, đau tăng, bụng dưới căng: ngừng dịch rửa vào, kiểm tra dây gập và gọi bác sĩ; không cố bơm để thông bằng áp lực.

Chảy máu tăng, tụt huyết áp, nghi thủng hoặc nhiễm khuẩn: báo bác sĩ ngay, hỗ trợ cấp cứu, lấy xét nghiệm theo chỉ định. Không tự chọn kháng sinh hoặc thay catheter ngoài phân công.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [7], [8], [15]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

04 RỬA BÀNG QUANG LẤY MÁU CỤC

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Rửa bàng quang lấy máu cục là kỹ thuật nhằm làm sạch máu cục trong lòng bàng quang bằng cách đưa một lượng dịch vô trùng vào bàng quang và sau đó dẫn lưu ra ngoài qua sonde bàng quang.

2. CHỈ ĐỊNH

Máu cục gây hoặc đe dọa tắc dẫn lưu bàng quang, có chỉ định của bác sĩ tiết niệu. Trường hợp không giải quyết được qua catheter cần bác sĩ đánh giá can thiệp khác.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nghi tổn thương niệu đạo, thủng bàng quang hoặc chưa xác định an toàn của đường dẫn lưu: không thực hiện cho đến khi bác sĩ tiết niệu đánh giá. Không bơm rửa qua catheter sai vị trí hoặc chưa xác nhận thông suốt.

4. THẬN TRỌNG

Phẫu thuật tiết niệu gần đây, bàng quang tổn thương, rối loạn đông máu, đau nhiều hoặc người bệnh không ổn định cần bác sĩ đánh giá trước. Duy trì hệ thống kín và thao tác áp lực thấp; không cố bơm khi gặp sức cản [7,8].

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng.

5.2. Thuốc

NaCl 0,9% vô khuẩn theo chỉ định; sát khuẩn phù hợp. Dịch và lượng bơm bóng theo hướng dẫn catheter, không mặc định 30 ml.

5.3. Vật tư

Sonde bàng quang.

Săng vô khuẩn loại có lỗ.

Săng vô khuẩn loại không có lỗ.

Gạc vô trùng.

Găng tay vô trùng.

Găng tay sạch.

Túi đựng nước tiểu.

Bộ dụng cụ thủ thuật.

Khẩu trang phẫu thuật.

Mũ phẫu thuật.

Quần áo vô khuẩn.

Bơm tiêm đầu nối catheter 50–60 ml khi rửa bằng tay; catheter thích hợp, catheter ba nhánh nếu rửa liên tục.

Gel bôi trơn vô khuẩn tan trong nước khi có chỉ định đặt catheter.

5.4. Trang thiết bị

Giường thủ thuật.

5.5. Người bệnh

Giải thích cho người bệnh lý do rửa bàng quang, quy trình rửa diễn ra như thế nào và biến chứng có thể xảy ra.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho người bệnh tiến hành làm thủ thuật.

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 20 phút - 30 phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, chỉ định, loại catheter, vị trí, độ thông và tình trạng người bệnh; giải thích, bảo đảm riêng tư, ghi sinh hiệu và đau trước thao tác.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn, dung dịch NaCl 0,9% theo chỉ định; ưu tiên hệ thống rửa kín thích hợp. Nếu cần đặt hoặc thay catheter, thực hiện theo quy trình thông tiểu riêng, không lấy độ sâu 10 cm làm quy tắc cho mọi người bệnh.

6.3. Bước 3: Chỉ bơm bóng sau khi xác nhận catheter đúng vị trí. Dùng loại dịch và thể tích ghi trên catheter hoặc hướng dẫn nhà sản xuất; không mặc định bóng 30 ml cho mọi trường hợp.

6.4. Bước 4: Kết nối đúng nhánh rửa, dẫn lưu và bóng chèn. Khi lấy máu cục bằng tay, sử dụng bơm tiêm đầu nối catheter 50–60 ml phù hợp, bơm và hút nhẹ theo chỉ định, không tạo áp lực cưỡng bức.

6.5. Bước 5: Rửa liên tục khi có y lệnh: dùng catheter ba nhánh và hệ thống kín; điều chỉnh theo màu dịch ra, mức chảy máu và độ thông. Theo dõi liên tục dòng ra, không để dịch vào khi đường ra tắc.

6.6. Bước 6: Kết thúc hoặc chuyển sang rửa liên tục theo bác sĩ; cố định catheter, giữ túi thấp hơn bàng quang, ghi lượng dịch vào và tổng dịch ra, màu sắc, máu cục và đáp ứng.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi đau, căng bàng quang, dòng chảy, màu dịch và sinh hiệu. Nước tiểu thực = tổng dịch dẫn lưu ra trừ tổng dịch rửa vào trong cùng khoảng thời gian; ghi riêng hai lượng để đánh giá cân bằng.

Dòng ra giảm hoặc ngừng, đau tăng, bụng dưới căng: ngừng dịch rửa vào, kiểm tra dây gập và gọi bác sĩ; không cố bơm để thông bằng áp lực.

Chảy máu tăng, tụt huyết áp, nghi thủng hoặc nhiễm khuẩn: báo bác sĩ ngay, hỗ trợ cấp cứu, lấy xét nghiệm theo chỉ định. Không tự chọn kháng sinh hoặc thay catheter ngoài phân công.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [7], [8], [15]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

05 THỞ OXY QUA MẶT NẠ CÓ TÚI

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Mặt nạ có túi dự trữ gồm loại thở lại một phần và loại không thở lại. Phải xác định đúng loại trước sử dụng; FiO2 thực tế phụ thuộc thiết kế, độ kín và thông khí người bệnh, không mặc định đạt 100%.

2. CHỈ ĐỊNH

Giảm oxy máu cần nồng độ oxy cao hơn gọng kính, đặc biệt trong cấp cứu ở người bệnh còn tự thở; bác sĩ đánh giá phương thức hỗ trợ phù hợp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không phải phương tiện đủ để xử trí ngừng thở hoặc thông khí không hiệu quả. Khi đó cần hỗ trợ thông khí và gọi cấp cứu ngay. Không xem COPD là chống chỉ định tuyệt đối với oxy.

4. THẬN TRỌNG

Theo dõi nguy cơ tăng CO2 và khả năng bảo vệ đường thở. Mục tiêu oxy theo bác sĩ; tham khảo mục 01. Không để túi xẹp hoặc nguồn oxy bị gián đoạn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng.

5.2. Thuốc

Oxy y tế theo mục tiêu và chỉ định; không tự thêm thuốc.

5.3. Vật tư

Mặt nạ hít lại một phần.

Mặt nạ không hít lại.

5.4. Trang thiết bị

Nguồn oxy, lưu lượng kế, máy đo SpO2; hệ làm ẩm khi có chỉ định và tương thích.

5.5. Người bệnh

- người bệnh được giải thích các lợi ích, nguy cơ của thủ thuật. Động viên người bệnh hợp tác thở.

- Đảm bảo đường thở thông thoáng.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 05 phút - 10phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Đánh giá người bệnh, mục tiêu SpO2 và loại mặt nạ. Kiểm tra nguồn oxy, dây, túi và van một chiều nếu có.

6.2. Bước 2: Mặt nạ không thở lại: thường dùng 10–15 lít/phút ở người lớn, cấp cứu thường khởi đầu 15 lít/phút; tuân thủ giới hạn nhà sản xuất. Loại thở lại một phần sử dụng theo hướng dẫn riêng của thiết bị.

6.3. Bước 3: Làm phồng túi trước khi đặt lên mặt; chỉnh mặt nạ vừa khít mũi miệng, không gây tì đè quá mức.

6.4. Bước 4: Quan sát túi trong thì hít vào và điều chỉnh để túi không xẹp hoàn toàn. Đánh giá SpO2, ý thức và công thở ngay sau đặt.

6.5. Bước 5: Nếu oxy hóa hoặc thông khí không cải thiện, gọi bác sĩ để hỗ trợ cao hơn; ghi loại mặt nạ, lưu lượng, mục tiêu, SpO2 và đáp ứng.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi SpO2, nhịp thở, ý thức, huyết động, khí máu theo chỉ định và độ kín mặt nạ.

Túi xẹp, tụt SpO2: kiểm tra ngay nguồn và lưu lượng, dây, van và mặt nạ; đánh giá người bệnh, gọi hỗ trợ nếu không cải thiện.

Nôn, hít sặc hoặc suy giảm ý thức: xử trí đường thở theo tình trạng, gọi bác sĩ. Theo dõi tăng CO2 ở người có nguy cơ và phòng cháy oxy.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [5]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

06 CHĂM SÓC CANUYN MỞ KHÍ QUẢN

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Duy trì đường dẫn khí, hạn chế nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm khuẩn vết mở, duy trì canuyn mở khí quản (MKQ) đúng vị trí.

2. CHỈ ĐỊNH

Áp dụng cho tất cả người bệnh có canuyn mở khí quản .

Thời gian thực hiện: Buổi sáng hoặc khi băng thấm dịch, máu .

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có

4. THẬN TRỌNG

Khi thay dây cố định phải có hai người: một người giữ liên tục ống đúng vị trí, người còn lại thực hiện. Không tháo hết cố định khi chưa có người giữ. Đánh giá kích thích và nguyên nhân; không buộc tay thường quy. Ống mới đặt hoặc lỗ mở mới cần đặc biệt thận trọng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

02 điều dưỡng đã được đào tạo: một người giữ ống liên tục, một người chăm sóc; bác sĩ hỗ trợ khi cần.

5.2. Thuốc

NaCl 0,9% để làm sạch; sản phẩm sát khuẩn chỉ theo chỉ định và tương thích mô, thiết bị.

5.3. Vật tư

Dụng cụ rửa tay

Dụng cụ chăm sóc

thay băng vô khuẩn.

Bộ dụng cụ hút đờm.

Túi đựng đồ bẩn.

Gạc mở khí quản cắt sẵn không xơ và dây cố định phù hợp.

5.4. Trang thiết bị

máy theo dõi (nếu cần).

Đồng hồ đo áp lực cuff, hiển thị cmH2O, đã kiểm tra hoạt động.

5.5. Người bệnh

- người bệnh được đánh giá và hút đờm khi có chỉ định.

- Đặt người bệnh ở tư thế nằm ngửa.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 10 phút - 15phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, giải thích và đánh giá hô hấp, SpO2; chuẩn bị hai người cùng phương tiện cấp cứu đường thở. Kiểm tra loại canuyn và thời gian mở khí quản.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, mang phương tiện phòng hộ. Một người giữ canuyn liên tục; người còn lại tháo băng bẩn, đánh giá da, dịch, máu và dấu hiệu nhiễm khuẩn.

6.3. Bước 3: Vệ sinh tay và sử dụng dụng cụ vô khuẩn phù hợp. Làm sạch nhẹ quanh lỗ mở bằng NaCl 0,9%, thấm khô; thuốc sát khuẩn chỉ theo chỉ định và tính tương thích, không dùng oxy già thường quy.

6.4. Bước 4: Chăm sóc nòng trong nếu loại canuyn có nòng trong, theo hướng dẫn nhà sản xuất. Không tự rút hoặc thay toàn bộ canuyn chỉ vì thấy dịch nghi nhiễm khuẩn.

6.5. Bước 5: Đặt gạc mở khí quản đã cắt sẵn, không xơ; thay và cố định dây mới trong khi người phụ vẫn giữ canuyn. Kiểm tra độ chắc, không quá chặt, không gây tì đè.

6.6. Bước 6: Với canuyn có bóng chèn, đo bằng đồng hồ; mục tiêu tham khảo người lớn 20–30 cmH2O, điều chỉnh theo bác sĩ và thiết bị [6]. Đánh giá thông khí, ghi tình trạng lỗ mở và chăm sóc.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi vị trí ống, độ chắc cố định, áp lực cuff, SpO2, thông khí và tổn thương da niêm mạc. Ghi kết quả mỗi lần kiểm tra.

Tuột, tắc hoặc nghi sai vị trí: gọi ngay bác sĩ và đội cấp cứu đường thở, hỗ trợ oxy hóa và thông khí theo quy trình cấp cứu. Không luồn lại mù qua lỗ mở mới và không tự đẩy ống nội khí quản vào.

Chảy máu, nhiễm khuẩn, rò khí kéo dài hoặc áp lực cuff bất thường: báo bác sĩ đánh giá; không mặc định thay toàn bộ ống hoặc tự dùng kháng sinh.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [6]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

07 CHĂM SÓC ỐNG NỘI KHÍ QUẢN

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Duy trì khai thông đường dẫn khí, hạn chế nhiễm trùng đường hô hấp.

Đảm bảo đúng vị trí cố định của ống nội khí quản (NKQ).

2. CHỈ ĐỊNH

Áp dụng cho tất cả người bệnh có ống NKQ.

Thời gian thực hiện: Buổi sáng, khi băng bẩn hoặc có dấu hiệu lỏng vị trí cố định.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

không có.

4. THẬN TRỌNG

Khi thay dây cố định phải có hai người: một người giữ liên tục ống đúng vị trí, người còn lại thực hiện. Không tháo hết cố định khi chưa có người giữ. Đánh giá kích thích và nguyên nhân; không buộc tay thường quy. Ống mới đặt hoặc lỗ mở mới cần đặc biệt thận trọng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

02 điều dưỡng đã được đào tạo: một người giữ ống liên tục, một người chăm sóc; bác sĩ hỗ trợ khi cần.

5.2. Thuốc

Nước muối Natriclorua 0,9% 100ml.

5.3. Vật tư

Dụng cụ rửa tay

Dụng cụ chăm sóc

thay băng vô khuẩn.

Khăn bông hoặc khăn giấy.

Bộ dụng cụ hút đờm.

Túi đựng đồ bẩn.

5.4. Trang thiết bị

máy theo dõi (nếu cần).

Đồng hồ đo áp lực cuff, hiển thị cmH2O, đã kiểm tra hoạt động.

5.5. Người bệnh

- Thông báo, giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh tỉnh)

- người bệnh được đánh giá và hút đờm khi có chỉ định

- Đặt gười bệnh ở tư thế thích hợp : Nằm ngửa thẳng, đầu cao 30 độ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 10 phút - 15phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, giải thích và đánh giá hô hấp, SpO2; chuẩn bị hai người cùng phương tiện cấp cứu. Đối chiếu vạch ống tại răng hoặc môi với vị trí đã được bác sĩ xác nhận.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, mang phương tiện phòng hộ. Một người giữ ống liên tục, người còn lại tháo cố định cũ và làm sạch da, miệng theo quy trình. Không lấy độ sâu cố định theo giới tính để tự chỉnh ống.

6.3. Bước 3: Nếu cần đổi điểm tì đè ở khóe miệng, giữ nguyên độ sâu đã xác nhận; không tự đẩy hoặc rút ống. Cố định mới đúng vạch và kiểm tra độ chắc, bảo vệ da.

6.4. Bước 4: Đo cuff bằng đồng hồ: mục tiêu tham khảo người lớn 20–30 cmH2O, cá thể hóa theo bác sĩ và loại ống [6]. Không bơm theo cảm giác hoặc tự tăng áp lực để xử trí mọi rò khí.

6.5. Bước 5: Kiểm tra lại vạch ống, SpO2, thông khí hai bên và báo động máy thở; bác sĩ xác minh vị trí bằng phương tiện phù hợp khi nghi di lệch.

6.6. Bước 6: Thu dọn, vệ sinh tay; ghi vạch ống trước và sau chăm sóc, áp lực cuff, da niêm mạc, diễn biến và người thực hiện.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi vị trí ống, độ chắc cố định, áp lực cuff, SpO2, thông khí và tổn thương da niêm mạc. Ghi kết quả mỗi lần kiểm tra.

Tuột, tắc hoặc nghi sai vị trí: gọi ngay bác sĩ và đội cấp cứu đường thở, hỗ trợ oxy hóa và thông khí theo quy trình cấp cứu. Không luồn lại mù qua lỗ mở mới và không tự đẩy ống nội khí quản vào.

Chảy máu, nhiễm khuẩn, rò khí kéo dài hoặc áp lực cuff bất thường: báo bác sĩ đánh giá; không mặc định thay toàn bộ ống hoặc tự dùng kháng sinh.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [6]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

08 HÚT ĐỜM ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI BẰNG HỆ THỐNG HÚT KÍN

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

- Hút đờm là một kỹ thuật cơ bản rất quan trọng ở người bệnh có can thiệp nội khí quản, mở khí quản trong hồi sức cấp cứu nhằm khai thông và kiểm soát đường thở cho người bệnh. Hút đờm không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề (tổn thương đường hô hấp, nhiễm trùng, tăng áp lực nội sọ…).

- Đặc biệt đối với các trường hợp người bệnh có tổn thương phổi nặng, liệt cơ hô hấp, việc làm gián đoạn đường thở còn làm tăng nguy cơ tử vong cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có NKQ hoặc MKQ bị ứ đọng đờm, ho không hiệu quả, dấu hiệu tắc hoặc thay đổi thông khí có liên quan đờm. Không hút đường thở thường quy cho mọi trẻ sơ sinh; bộ này áp dụng người lớn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối khi cần giải phóng đường thở. Đánh giá lợi ích và nguy cơ ở người bệnh giảm oxy máu nặng, huyết động không ổn định hoặc dễ loạn nhịp. Chọn hệ thống tương thích ống và phương thức thở.

4. THẬN TRỌNG

Hút có thể gây giảm oxy máu, tổn thương niêm mạc, loạn nhịp và tăng áp lực nội sọ. Cần nhân viên được đào tạo, phương tiện cấp cứu và theo dõi liên tục [4].

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

02 điều dưỡng đã được đào tạo khi tình trạng cần hỗ trợ: một người hút, một người theo dõi và hỗ trợ; không bắt buộc vỗ rung hoặc đổi đủ ba tư thế.

5.2. Thuốc

Dung dịch sát khuẩn tay; dung dịch rửa catheter theo hướng dẫn bộ hút, chỉ dùng tại buồng rửa khi catheter đã rút hoàn toàn, không bơm thường quy vào đường thở.

5.3. Vật tư

Dụng cụ rửa tay

Dụng cụ chăm sóc

thay băng vô khuẩn. .

Ống hút đờm kín.

Ống hút dịch thường.

Khăn bông hoặc khăn giấy .

Túi đựng đồ bẩn.

Catheter hút chọn theo ống đường thở của người lớn; loại vô khuẩn dùng một lần khi hút mở, hoặc hệ hút kín tương thích khi hút kín; dụng cụ hút miệng riêng.

5.4. Trang thiết bị

Máy hút đờm hoặc hệ thống hút đờm trung tâm.

máy theo dõi Mornitor.

5.5. Người bệnh

- Thông báo và giải thích cho người bệnh hoặc người nhà để người bệnh yên tâm tin tưởng và hợp tác khi tiến hành kỹ thuật.

- Hướng dẫn người bệnh ho, thở sâu, vỗ rung(nếu cần)

- Tư thế người bệnh thoải mái, thuận tiện cho kỹ thuật.

- Trải khăn dưới cằm người bệnh.

Đánh giá nhu cầu tiền oxy hóa và dung nạp theo tình trạng; không áp dụng FiO2 100% kéo dài thường quy.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 10 phút - 15phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, chỉ định hút do ứ đọng đờm, thông khí giảm hoặc dấu hiệu tắc; đánh giá SpO2, nhịp tim, huyết động và thông số máy thở.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, mang phòng hộ; chọn catheter có đường kính ngoài dưới 50% đường kính trong ống ở người lớn. Đặt áp lực âm thấp nhất có hiệu quả, đúng thiết bị; có thể khởi đầu 80–120 mmHg theo tình trạng, không lấy mức tối đa làm áp lực mặc định.

6.3. Bước 3: Tiền oxy hóa theo đánh giá và phương thức thở, theo dõi đáp ứng; tránh ngắt hỗ trợ hô hấp không cần thiết. Không áp dụng tự động FiO2 100% kéo dài cho mọi người bệnh.

6.4. Bước 4: Hút nông trước, đưa catheter tới chiều sâu đã xác định theo chiều dài ống, không hút khi đưa vào, không cố tiến tới sức cản hoặc carina. Hút sâu chỉ cân nhắc khi hút nông không hiệu quả và có đánh giá phù hợp.

6.5. Bước 5: Áp dụng hút trong khi rút nhẹ catheter, mỗi lượt tối đa 15 giây. Cho người bệnh hồi phục oxy hóa giữa các lượt; chỉ lặp lại khi còn chỉ định và người bệnh dung nạp, không bắt buộc hút đủ ba tư thế.

6.6. Bước 6: Không nhỏ NaCl 0,9% hoặc NaHCO3 thường quy vào đường thở. Dừng ngay khi giảm oxy máu đáng kể, nhịp chậm hoặc loạn nhịp, đau hoặc suy giảm huyết động; không chờ mạch dưới 40 lần/phút mới dừng.

6.7. Bước 7: Hút kín: giữ hệ thống kín và bao bảo vệ nguyên vẹn. Sau hút, rút catheter hoàn toàn về buồng rửa, rửa theo hướng dẫn bộ hút, không để dịch vào người bệnh; khóa van và kiểm tra đầu catheter đã ra khỏi lòng ống. Thay hệ thống theo hướng dẫn và khi nhiễm bẩn hoặc hỏng.

6.8. Bước 8: Kết thúc, khôi phục thông số oxy theo chỉ định khi ổn định; đánh giá đáp ứng, thu dọn, vệ sinh tay và ghi số lượt, tính chất đờm, SpO2 và biến cố.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi SpO2, nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, áp lực đường thở và đáp ứng trước, trong, sau hút. Hút theo chỉ định lâm sàng, không chỉ theo lịch cố định.

Giảm oxy máu, loạn nhịp hoặc suy giảm huyết động: dừng hút, hỗ trợ oxy hóa và thông khí, gọi bác sĩ; xử trí cấp cứu nếu ngừng tuần hoàn.

Chảy máu, tổn thương niêm mạc, co thắt, tăng áp lực nội sọ hoặc nghi nhiễm khuẩn: dừng hoặc điều chỉnh thao tác, báo bác sĩ đánh giá và thực hiện chỉ định. Bảo đảm vô khuẩn khi hút mở [4].

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [4]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

09 VỖ RUNG LỒNG NGỰC Ở NGƯỜI BỆNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỌC

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Vỗ rung là phương pháp điều trị nhằm giải phóng đờm dịch ra khỏi phổi nhờ chủ động tác động một lực cơ học qua thành ngực truyền vào phổi, làm các cục đờm ứ đọng dính vào phế quản nhỏ bị bong ra rồi đờm được dẫn lưu vào phế quản lớn và ho tống ra ngoài hoặc được hút bằng sonde hút đờm.

2. CHỈ ĐỊNH

Ứ đọng đờm và khó tự làm sạch đường thở, có chỉ định hỗ trợ dẫn lưu đờm sau đánh giá. Không vỗ rung thường quy chỉ vì người bệnh có COPD, hen hoặc đang thở máy.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- người bệnh đang trong tình trạng nặng: Suy hô hấp cấp, phù phổi cấp, sốc, trụy tim mạch…

- người bệnh sau mổ dẫn lưu nội sọ, tăng áp lực nội sọ, xuất huyết não những ngày đầu.

- Bệnh tim mạch : Nhồi máu cơ tim cấp, suy tim nặng..

- Chấn thương phổi, xuất huyết phổi.

- người bệnh gẫy xương sườn chưa cố định.

- người bệnh có dẫn lưu màng phổi (chống chỉ định tương đối).

4. THẬN TRỌNG

Đánh giá đau, tổn thương xương sườn, chảy máu, tăng áp lực nội sọ và dung nạp hô hấp. Tư thế dẫn lưu theo vị trí tổn thương; không tự chọn đầu thấp ở người có nguy cơ hít sặc hoặc chống chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

02 Điều dưỡng hoặc 01 điều dưỡng và 01 kỹ thuật viên, được đào tạo chuyên khoa hồi sức cấp cứu.

5.2. Thuốc

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Xà phòng diệt khuẩn.

5.3. Vật tư

Găng sạch: 01 đôi.

Khăn bông to: 01 cái.

Mũ: 02 cái.

Khẩu trang: 02 cái.

Bóng

Mask.

5.4. Trang thiết bị

Thiết bị phù hợp đã kiểm tra hoạt động; phương tiện theo dõi và cấp cứu theo tình trạng.

5.5. Người bệnh

- Thông báo ,giải thích cho người bệnh (nếu tỉnh) hoặc người nhà lợi ích của việc vỗ rung lồng ngực, động viên họ cùng hợp tác.

Tư thế theo vị trí tổn thương và mức dung nạp, tránh đầu thấp khi có nguy cơ hít sặc hoặc chống chỉ định.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 15 phút - 20phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1. Điều dưỡng đội mũ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh, đeo khẩu trang.

6.2. Bước 2. Thông báo, giải thích, động viên người bệnh cùng hợp tác.

6.3. Bước 3. Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp, tiến hành vỗ trước, rung sau.

Kỹ thuật vỗ:

Điều dưỡng dùng hai bàn tay chụm các ngón tay, khum lòng bàn tay vỗ đều lên thành ngực hoặc vùng lưng, sao cho các cạnh của bàn tay tiếp xúc với thành ngực hoặc vùng lưng (nếu vỗ lưng) chỉ sử dụng lực của bàn tay, hoạt động khớp cổ tay. Vỗ nhẹ nhàng đều đặn dịch chuyển trên lồng ngực hoặc vùng lưng. Việc vỗ rung tạo ra áp lực dương tác dụng lên thành ngực và vào phổi làm cho đờm dãi và mủ long ra và dồn từ các nhánh với phế quản nhỏ về nhánh phế quản lớn hơn. Thời gian và lực tùy dung nạp, đánh giá lại thường xuyên; không cố vỗ liên tục 10–15 phút mỗi bên.

Lưu ý: Khi vỗ rung chỉ tập trung vỗ lên bề mặt khung sườn, tránh vỗ lên cột sống, xương ức, dạ dày và phần dưới khung sườn vì có thể gây chấn thương cho lách, gan, thận và các tạng ở thấp.

Kỹ thuật rung:

Điều dưỡng duỗi bàn tay đặt bàn tay lên thành ngực, vùng lưng (nếu rung ở lưng) tương ứng với phân thuỳ phổi cần dẫn lưu, sử dụng lực rung của cơ cánh tay và vai tác động tới bàn tay truyền lực rung lên thành ngực và các phân thuỳ phổi tương ứng.

Chú ý: Động tác rung được thực hiện trong thời kỳ thở ra, yêu cầu người bệnh thở ra từ từ để dễ thực hiện nếu có thể. Khuyến khích người bệnh ho tống đờm ra ngoài, tiến hành hút đờm ngay sau đó.

6.4. Bước 4. Sau khi thực hiện xong kỹ thuật giúp người bệnh trở về tư thế thoải mái.

6.5. Bước 5. Điều dưỡng thu dọn dụng cụ. tháo găng (nếu đi găng), rửa tay .

6.6. Bước 6. Ghi phiếu chăm sóc.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi SpO2, mạch, nhịp thở, đau và sắc mặt trước, trong, sau thực hiện.

Ngừng khi giảm SpO2, khó thở, đau ngực, loạn nhịp hoặc huyết động xấu; hỗ trợ hô hấp và báo bác sĩ.

Khuyến khích ho hoặc kỹ thuật thở ra hỗ trợ khi thích hợp; hút đờm khi có chỉ định. Không yêu cầu nhịn ho hoặc cố gắng kéo dài vỗ rung khi không dung nạp.

Ghi thời điểm, nhận định, thao tác, đáp ứng, tai biến và xử trí; báo và bàn giao bất thường cho bác sĩ, ca trực tiếp theo. Nếu có biến cố đe dọa tính mạng, gọi hỗ trợ và ưu tiên cấp cứu theo quy trình bệnh viện.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

10 CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

người bệnh thở máy là những người bệnh cần được hỗ trợ hô hấp hoàn toàn hoặc một phần. Có hai phương pháp thông khí nhân tạo (TKNT):

+ Thở máy xâm nhập: TKNT qua nội khí quản hoặc canun mở khí quản.

+ Thở máy không xâm nhập: TKNT qua mặt nạ mũi hoặc mặt nạ mũi và miệng.

- người bệnh thở máy thường là nặng, đặc biệt người bệnh suy hô hấp cấp tiến triển nếu để tuột máy thở có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

người bệnh nặng này cần có nhiều máy truyền dịch, bơm tiêm điện, ống thông dạ dày. Do vậy công việc chăm sóc khó khăn và cần phải có người hỗ trợ.

2. CHỈ ĐỊNH

người bệnh thở máy xâm nhập.

người bệnh thở máy không xâm nhập.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

4. THẬN TRỌNG

Người bệnh phụ thuộc máy thở, huyết động không ổn định hoặc mất khả năng bảo vệ đường thở cần giám sát sát. Không tự tháo máy để ăn hoặc ho; tư thế và hỗ trợ khi tạm ngắt máy phải có đánh giá và kế hoạch phù hợp.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sỹ và điều dưỡng được đào tạo chuyên khoa về hồi sức cấp cứu.

5.2. Thuốc

Natriclorua 0,9%

Povidin 10%

dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

nước cất máy thở

5.3. Vật tư

Găng tay sạch

mâm vô khuẩn

gạc miếng vô khuẩn

bơm tiêm 10ml

bơm tiêm 20ml

dây truyền

ống hút đờm

khay quả đậu vô khuẩn

Pen vô khuẩn

kẹp phẫu tích

bình kiềm

mũ

khẩu trang

Bóng Ambu

mặt nạ bóp bóng.

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

mở khí quản cấp cứu.

Xe cấp cứu đầy đủ các phương tiện cấp cứu ngừng tuần hoàn tại giường.

kim lấy thuốc

dây máy thở dùng 1 lần

5.4. Trang thiết bị

máy theo dõi

máy hút áp lực âm

máy thở

5.5. Người bệnh

Định danh, giải thích và đánh giá tình trạng, đặt tư thế an toàn, bảo đảm riêng tư.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 20 phút - 30phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, y lệnh, mode và thông số máy, mục tiêu SpO2, giới hạn báo động; đánh giá người bệnh và nguồn điện, khí, pin dự phòng. Chuẩn bị bóng và phương tiện cấp cứu.

6.2. Bước 2: Chăm sóc NKQ hoặc MKQ theo quy trình tương ứng, kiểm tra vạch ống, cố định và cuff; hút đờm khi có chỉ định, không vỗ rung thường quy cho mọi người bệnh.

6.3. Bước 3: NIV: chọn mặt nạ đúng cỡ, kiểm tra rò khí, bảo vệ sống mũi và đánh giá khả năng bảo vệ đường thở. Việc ăn uống và tạm ngắt NIV phải có bác sĩ đánh giá, phương án oxy hoặc hỗ trợ thay thế và người giám sát.

6.4. Bước 4: Duy trì dây máy thở, bẫy nước và hệ thống làm ẩm đúng thiết kế. Xử lý nước ngưng tránh chảy vào người bệnh, không tự mở hệ thống; dùng nước vô khuẩn phù hợp và nhiệt độ theo hướng dẫn, không mặc định 2.000 ml/ngày.

6.5. Bước 5: Nâng đầu 30–45 độ nếu dung nạp và không chống chỉ định. Khi sốc, chọn tư thế theo đánh giá bác sĩ, không đặt đầu thấp thường quy. Chăm sóc miệng, dinh dưỡng, vận động và dự phòng tổn thương do tì đè theo kế hoạch.

6.6. Bước 6: Kiểm tra, ghi sinh hiệu và thông số theo mức độ nặng; đánh giá báo động bằng quan sát người bệnh trước, không tắt báo động để bỏ qua sự cố. Ghi chăm sóc và bàn giao những bất thường.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi hô hấp, SpO2, huyết động, đồng bộ máy, khí máu theo chỉ định, dịch vào ra, dinh dưỡng và da.

Suy hô hấp đột ngột: gọi bác sĩ, kiểm tra tắc hoặc tuột ống, dây máy, nguồn khí và tràn khí màng phổi; hỗ trợ thông khí cấp cứu theo quy trình. Giải áp hoặc dẫn lưu do người có thẩm quyền và năng lực thực hiện.

Nghi hít sặc hoặc viêm phổi: xử trí đường thở, báo bác sĩ, lấy xét nghiệm theo chỉ định. Kháng sinh dựa trên đánh giá lâm sàng; không tự dùng kháng sinh phổ rộng cho mọi trường hợp.

Dự phòng loét tiêu hóa và huyết khối theo nguy cơ, chống chỉ định và y lệnh. Thay đổi tư thế cá thể hóa; giảm tì đè vùng da đỏ, không xoa bóp vùng đỏ do áp lực. Ghi và bàn giao diễn biến.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

11 ĐO ÁP LỰC CỦA BÓNG CHÈN Ở NGƯỜI BỆNH ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN HOẶC MỞ KHÍ QUẢN

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản hoặc mở khí quản là đảm bảo bóng chèn có một áp lực hợp lý tác dụng lên khí quản của người bệnh để đạt được mục đích của bóng chèn và không gây tai biến cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có NKQ hoặc MKQ có bóng chèn, cần đo và duy trì áp lực cuff phù hợp; tần suất theo quy định đã phê duyệt và khi có dấu hiệu rò khí hoặc thay đổi tình trạng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối.

Không nên đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản, mở khí quản khi người bệnh đang kích thích ho, co giật, co thắt phế quản…

4. THẬN TRỌNG

Chỉ áp dụng với ống có bóng chèn và đồng hồ đo phù hợp. Mục tiêu tham khảo người lớn 20–30 cmH2O; một số loại ống hoặc bệnh cảnh cần mục tiêu riêng của bác sĩ và nhà sản xuất [6].

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng đã được đào tạo chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

5.2. Thuốc

dung dịch sát khuẩn phù hợp

dung dịch sát khuẩn tay nhanh

5.3. Vật tư

gạc miếng vô khuẩn

mũ

khẩu trang.

5.4. Trang thiết bị

Đồng hồ đo áp lực cuff

Đồng hồ đo áp lực cuff, hiển thị cmH2O, đã kiểm tra hoạt động.

5.5. Người bệnh

Thông báo giải thích cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh biết việc sắp làm.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 05 phút - 15phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, giải thích, kiểm tra ống, vạch cố định, thông khí và tình trạng rò khí; vệ sinh tay.

6.2. Bước 2: Kiểm tra đồng hồ đo và đơn vị cmH2O, kết nối với van cuff đúng hướng dẫn thiết bị.

6.3. Bước 3: Đọc và điều chỉnh áp lực tới mục tiêu được xác định. Tránh thất thoát khí do thao tác, không bơm theo cảm giác hoặc quy đổi nhầm mmHg sang cmH2O.

6.4. Bước 4: Tháo đồng hồ, kiểm tra thông khí và rò khí; ghi trị số, thời điểm và điều chỉnh. Làm sạch, khử khuẩn thiết bị theo nhà sản xuất.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Đề xuất kiểm tra mỗi ca và sau đổi tư thế, chăm sóc ống, thay cố định hoặc phát hiện rò khí; bệnh viện phê duyệt tần suất phù hợp từng đơn vị.

Áp lực thấp kéo dài, cao kéo dài hoặc phải bơm thêm liên tục: báo bác sĩ đánh giá bóng, vị trí và kích cỡ ống; không tăng áp lực vô hạn để hết rò.

Theo dõi tổn thương đường thở, hít sặc và thông khí; không xem cuff đúng áp lực là bảo đảm tuyệt đối không hít sặc.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [6]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

12 KHÍ DUNG CHO NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Khí dung thuốc nhằm đưa một lượng thuốc dưới dạng sương mù để điều trị chống viêm tại chỗ cũng như để điều trị co thắt phế quản, tắc nghẽn đường thở.

2. CHỈ ĐỊNH

Có chỉ định thuốc khí dung ở người bệnh thở máy, ví dụ co thắt phế quản. Tiền sử hen hoặc COPD, hoặc đờm đặc đơn thuần không tự tạo chỉ định cho mọi thuốc khí dung.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng hoặc chống chỉ định của thuốc dự kiến; chưa có thiết bị khí dung tương thích hệ thống thở. Bác sĩ cân nhắc trước thực hiện ở người bệnh chưa ổn định.

4. THẬN TRỌNG

Theo dõi ảnh hưởng đến thông khí, thể tích khí, áp lực, mạch và SpO2. Thuốc, liều, dung môi, vị trí thiết bị và xử lý HME hoặc bộ lọc phải theo hướng dẫn tương thích của máy thở và bộ khí dung.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng đã được đào tạo.

5.2. Thuốc

dung dịch sát khuẩn phù hợp

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh hoặc xà phòng rửa tay diệt khuẩn

thuốc khí dung theo chỉ định.

5.3. Vật tư

Bộ dây khí dung dùng riêng cho từng người bệnh.

Ống khí dung chữ T

Găng vô khuẩn : 01 đôi

Bơm tiêm 5ml : 01 cái

Mũ : 01 cái

Gạc vô khuẩn

Khẩu trang : 01 cái

Bóng Ambu

mặt nạ cấp cứu.

Kim lấy thuốc : 01 cái

5.4. Trang thiết bị

Máy khí dung

máy theo dõi

máy đo huyết áp

5.5. Người bệnh

Thông báo giải thích cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh về việc sắp làm.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 20 phút - 30phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, chỉ định, thuốc, liều, dị ứng và hệ thống máy thở; đánh giá mạch, SpO2, thông khí và thông số ban đầu.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, chuẩn bị thuốc và bộ khí dung đúng hướng dẫn. Budesonide là thuốc chống viêm, không phải thuốc giãn phế quản; không tự thêm thuốc hoặc dung dịch để làm loãng đờm.

6.3. Bước 3: Lắp thiết bị tại vị trí nhà sản xuất khuyến cáo. Không để HME hoặc bộ lọc chặn đường đưa aerosol tới người bệnh; việc di chuyển hoặc tháo lắp phải theo cấu hình an toàn, hạn chế ngắt mạch và duy trì chức năng bảo vệ phù hợp.

6.4. Bước 4: Vận hành với liều và thời gian theo thuốc, thiết bị, y lệnh; theo dõi đáp ứng, báo động và độ thông bộ lọc, không mặc định 30 phút cho mọi thiết bị.

6.5. Bước 5: Kết thúc, khôi phục đầy đủ cấu hình máy và HME hoặc bộ lọc theo hướng dẫn. Kiểm tra thông khí, xử lý thiết bị và ghi thuốc, liều, thời gian, đáp ứng.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi mạch, SpO2, huyết áp, thông khí, sức cản đường thở và báo động.

Khó thở tăng, co thắt, loạn nhịp hoặc nghi dị ứng: dừng khí dung, duy trì hỗ trợ hô hấp, gọi bác sĩ và xử trí theo tình trạng.

Nghi tắc hoặc hỏng bộ lọc, hệ thống khí dung: đánh giá người bệnh, gọi hỗ trợ, thay bộ phận phù hợp và kiểm tra lại toàn hệ thống.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [14]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

13 HÚT ĐỜM CHO NGƯỜI BỆNH CÓ ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN VÀ MỞ KHÍ QUẢN BẰNG ỐNG HÚT ĐỜM KÍN

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Hút đờm kín là một kỹ thuật đưa ống hút kín qua ống NKQ, MKQ hút sạch đờm trong ống NKQ, MKQ và trong khí quản của người bệnh. Đây là một kỹ thuật rất cơ bản trong hồi sức cấp cứu nhằm khai thông và kiểm soát đường thở người bệnh đã đặt ống NKQ, MKQ.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có NKQ hoặc MKQ bị ứ đọng đờm, ho không hiệu quả, dấu hiệu tắc hoặc thay đổi thông khí có liên quan đờm. Không hút đường thở thường quy cho mọi trẻ sơ sinh; bộ này áp dụng người lớn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối khi cần giải phóng đường thở. Đánh giá lợi ích và nguy cơ ở người bệnh giảm oxy máu nặng, huyết động không ổn định hoặc dễ loạn nhịp. Chọn hệ thống tương thích ống và phương thức thở.

4. THẬN TRỌNG

Hút có thể gây giảm oxy máu, tổn thương niêm mạc, loạn nhịp và tăng áp lực nội sọ. Cần nhân viên được đào tạo, phương tiện cấp cứu và theo dõi liên tục [4].

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

02 điều dưỡng đã được đào tạo khi tình trạng cần hỗ trợ: một người hút, một người theo dõi và hỗ trợ; không bắt buộc vỗ rung hoặc đổi đủ ba tư thế.

5.2. Thuốc

Dung dịch sát khuẩn tay; dung dịch rửa catheter theo hướng dẫn bộ hút, chỉ dùng tại buồng rửa khi catheter đã rút hoàn toàn, không bơm thường quy vào đường thở.

5.3. Vật tư

Dây hút silicon

ống hút đờm kín kích cỡ phù hợp.

Găng vô khuẩn : 01 đôi

Gạc vô khuẩn : 01 gói

Bơm tiêm 10ml : 02 cái

Găng sạch : 01 đôi

Mũ : 02 cái

Khẩu trang : 02 cái

Bóng Ambu

mặt nạ bóp bóng.

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản cấp cứu.

Catheter hút chọn theo ống đường thở của người lớn; loại vô khuẩn dùng một lần khi hút mở, hoặc hệ hút kín tương thích khi hút kín; dụng cụ hút miệng riêng.

5.4. Trang thiết bị

máy hút áp lực âm có thể điều chỉnh mức áp lực

máy huyết áp

máy theo dõi.

5.5. Người bệnh

Thông báo giải thích động viên, vỗ rung cho người bệnh (nếu cần).

Đặt người bệnh tư thế thích hợp.

Đánh giá nhu cầu tiền oxy hóa và dung nạp theo tình trạng; không áp dụng FiO2 100% kéo dài thường quy.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 20 phút - 30phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, chỉ định hút do ứ đọng đờm, thông khí giảm hoặc dấu hiệu tắc; đánh giá SpO2, nhịp tim, huyết động và thông số máy thở.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, mang phòng hộ; chọn catheter có đường kính ngoài dưới 50% đường kính trong ống ở người lớn. Đặt áp lực âm thấp nhất có hiệu quả, đúng thiết bị; có thể khởi đầu 80–120 mmHg theo tình trạng, không lấy mức tối đa làm áp lực mặc định.

6.3. Bước 3: Tiền oxy hóa theo đánh giá và phương thức thở, theo dõi đáp ứng; tránh ngắt hỗ trợ hô hấp không cần thiết. Không áp dụng tự động FiO2 100% kéo dài cho mọi người bệnh.

6.4. Bước 4: Hút nông trước, đưa catheter tới chiều sâu đã xác định theo chiều dài ống, không hút khi đưa vào, không cố tiến tới sức cản hoặc carina. Hút sâu chỉ cân nhắc khi hút nông không hiệu quả và có đánh giá phù hợp.

6.5. Bước 5: Áp dụng hút trong khi rút nhẹ catheter, mỗi lượt tối đa 15 giây. Cho người bệnh hồi phục oxy hóa giữa các lượt; chỉ lặp lại khi còn chỉ định và người bệnh dung nạp, không bắt buộc hút đủ ba tư thế.

6.6. Bước 6: Không nhỏ NaCl 0,9% hoặc NaHCO3 thường quy vào đường thở. Dừng ngay khi giảm oxy máu đáng kể, nhịp chậm hoặc loạn nhịp, đau hoặc suy giảm huyết động; không chờ mạch dưới 40 lần/phút mới dừng.

6.7. Bước 7: Hút kín: giữ hệ thống kín và bao bảo vệ nguyên vẹn. Sau hút, rút catheter hoàn toàn về buồng rửa, rửa theo hướng dẫn bộ hút, không để dịch vào người bệnh; khóa van và kiểm tra đầu catheter đã ra khỏi lòng ống. Thay hệ thống theo hướng dẫn và khi nhiễm bẩn hoặc hỏng.

6.8. Bước 8: Kết thúc, khôi phục thông số oxy theo chỉ định khi ổn định; đánh giá đáp ứng, thu dọn, vệ sinh tay và ghi số lượt, tính chất đờm, SpO2 và biến cố.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi SpO2, nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, áp lực đường thở và đáp ứng trước, trong, sau hút. Hút theo chỉ định lâm sàng, không chỉ theo lịch cố định.

Giảm oxy máu, loạn nhịp hoặc suy giảm huyết động: dừng hút, hỗ trợ oxy hóa và thông khí, gọi bác sĩ; xử trí cấp cứu nếu ngừng tuần hoàn.

Chảy máu, tổn thương niêm mạc, co thắt, tăng áp lực nội sọ hoặc nghi nhiễm khuẩn: dừng hoặc điều chỉnh thao tác, báo bác sĩ đánh giá và thực hiện chỉ định. Bảo đảm vô khuẩn khi hút mở [4].

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [4]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

14 CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm đã được đặt để duy trì đường truyền an toàn, phòng nhiễm khuẩn và phát hiện biến chứng. Áp dụng catheter ở các vị trí và số nòng phù hợp; không giới hạn catheter hai nòng.

2. CHỈ ĐỊNH

Áp dụng cho tất cả người bệnh có đặt catheter TMTT.

Thời gian thực hiện: Khi băng thấm dịch, máu, hoặc qua băng cố định thấy viêm đỏ, chảy máu quanh chân catheter.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối với việc chăm sóc cần thiết. Không thay băng chỉ vì đến một thời điểm tùy ý nếu chưa có chỉ định hoặc lịch phù hợp; loại sát khuẩn phải phù hợp dị ứng và thiết bị.

4. THẬN TRỌNG

Không tự đẩy catheter di lệch trở lại lòng mạch. Kiểm tra đường truyền thuốc vận mạch trước thao tác, tránh ngắt truyền, khí lọt hoặc bolus ngoài ý muốn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

1 điều dưỡng: rửa tay, đội mũ , đeo khẩu trang.

5.2. Thuốc

Sát khuẩn tay; sát khuẩn da ưu tiên chlorhexidine trên 0,5% trong cồn nếu không chống chỉ định; lựa chọn khác theo dị ứng, thiết bị và hướng dẫn. Dịch bơm rửa theo loại catheter và y lệnh.

5.3. Vật tư

Dụng cụ chăm sóc

thay băng vô khuẩn: 01 bộ .

Băng cố định: 01 miếng .

Túi đựng đồ bẩn : 01 cái .

Găng tay sạch: 01 cặp.

Khay hạt đậu: 01 cái .

Găng vô khuẩn: 01 cặp .

5.4. Trang thiết bị

Thiết bị phù hợp đã kiểm tra hoạt động; phương tiện theo dõi và cấp cứu theo tình trạng.

5.5. Người bệnh

- Thông báo, giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh tỉnh).

- Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp: Đầu cao 30 độ, nghiêng mặt về bên đối diện đặt catheter.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 10 phút - 20phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, đánh giá chỉ định còn cần catheter, vị trí, chiều dài ngoài da, băng và đường truyền; chuẩn bị vô khuẩn và giải thích.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, mang găng sạch tháo băng cũ, kiểm tra da và chân catheter; tháo găng, vệ sinh tay và dùng găng vô khuẩn khi thay băng.

6.3. Bước 3: Sát khuẩn da theo sản phẩm đã chọn, ưu tiên chlorhexidine trên 0,5% trong cồn nếu không chống chỉ định; dùng lựa chọn phù hợp khác khi cần. Để khô hoàn toàn trước băng [9].

6.4. Bước 4: Đặt băng vô khuẩn, cố định chắc, ghi ngày giờ. Với CVC ngắn hạn ở người lớn: băng gạc thường thay mỗi 2 ngày, băng trong suốt mỗi 7 ngày; thay sớm khi ẩm, bẩn hoặc bong, điều chỉnh theo loại catheter và hướng dẫn [9].

6.5. Bước 5: Sát khuẩn đầu nối và để khô trước mỗi lần tiếp cận; giữ hệ thống kín. Bơm rửa hoặc khóa catheter theo loại và chỉ định, không cố bơm khi tắc.

6.6. Bước 6: Ghi chăm sóc, vị trí, tình trạng da, chiều dài ngoài da và những bất thường; bàn giao thuốc và nhánh truyền.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi sốt, rét run, đau, đỏ, mủ, phù, chảy máu và chức năng catheter; báo bác sĩ khi nghi nhiễm khuẩn.

Tắc: kiểm tra dây và khóa, không cố bơm áp lực; báo bác sĩ đánh giá nguyên nhân và chỉ định xử trí. Catheter di lệch hoặc hỏng: ngừng sử dụng nhánh không an toàn, không đẩy vào lại.

Nghi nhiễm khuẩn huyết, khí lọt hoặc biến cố nặng: gọi cấp cứu; cấy máu, rút hoặc thay catheter theo quyết định bác sĩ, không mặc định rút và cấy đầu catheter mọi trường hợp.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [9]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

15 ĐẶT CATHETER NGOẠI VI

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Catheter ngoại vi là một kim nhựa có nòng, được dùng để đặt vào tĩnh mạch ngoại vi nhằm các mục đích sau:

- Duy trì đường truyền tĩnh mạch

- Chuẩn bị sẵn đường truyền để lấy máu xét nghiệm, truyền dịch và thực hiện thuốc.

- Tránh tuột đường truyền khi vận chuyển người bệnh.

- Đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi là thủ thuật cơ bản của điều dưỡng.

2. CHỈ ĐỊNH

Khi cần truyền dịch, lấy máu xét nghiệm và thực hiện tiêm, truyền thuốc.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không đặt tại vùng nhiễm khuẩn, bỏng hoặc tổn thương mạch; tránh chi có đường thông động tĩnh mạch và vùng có chống chỉ định. Rối loạn đông máu cần đánh giá nguy cơ và lựa chọn phù hợp, không mặc định cấm mọi đường truyền ngoại vi.

4. THẬN TRỌNG

Chọn vị trí và cỡ catheter theo tình trạng mạch, thuốc và thời gian điều trị; tránh vùng nhiễm khuẩn, chi có tổn thương hoặc đường thông động tĩnh mạch. Đánh giá nguy cơ thoát mạch của thuốc.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

01 điều dưỡng

Giải thích cho người bệnhvà người nhà trước khi làm thủ thuật.

Trang bị mũ, khẩu trang.

Vệ sinh bàn tay, đi găng tay vô trùng.

5.2. Thuốc

dịch truyền dung dịch natri chlorua 0,9%

5.3. Vật tư

Gói dụng cụ tiêu hao

Gói dụng cụ rửa tay

Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân

Bộ dụng cụ tiêm truyền vô khuẩn

Catheter ngoại vi các cỡ

bộ dây truyền

khoá ba chạc

băng dính

opside.

Gối kê tay

bàn thủ thuật

săng vô khuẩn có lỗ và không lỗ.

5.4. Trang thiết bị

máy theo dõi

Máy truyền dịch

5.5. Người bệnh

Giải thích, đánh giá sinh hiệu, chọn tĩnh mạch theo tình trạng và thuốc; đặt tư thế an toàn, hỗ trợ chi khi thao tác, không cố định tay chân thường quy.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

trung bình 05phút - 10phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, chỉ định, dị ứng và lựa chọn catheter; giải thích, đặt tư thế thuận tiện, bảo đảm riêng tư.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, mang găng phù hợp, buộc garô và chọn tĩnh mạch; sát khuẩn da theo sản phẩm, để khô, không chạm lại vị trí đã sát khuẩn nếu không bảo đảm vô khuẩn.

6.3. Bước 3: Đưa catheter đúng kỹ thuật của loại đang dùng; khi xác nhận vào mạch, luồn phần nhựa và rút kim an toàn. Không đưa kim trở lại lòng catheter nhựa.

6.4. Bước 4: Tháo garô, kết nối đầu nối và dây đã đuổi khí; kiểm tra độ thông bằng phương pháp phù hợp. Cố định và băng vô khuẩn, không che mất khả năng quan sát cần thiết.

6.5. Bước 5: Thu kim vào hộp sắc nhọn, thu dọn, vệ sinh tay; ghi vị trí, cỡ catheter, ngày giờ và người đặt.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi đau, phù, đỏ, viêm tĩnh mạch, rò hoặc thoát mạch; đánh giá nhu cầu duy trì và thay hoặc rút theo chỉ định, quy định bệnh viện.

Nghi thoát mạch: ngừng truyền, không bơm rửa, giữ catheter khi cần để hút hoặc dùng thuốc xử trí theo quy trình của thuốc; báo bác sĩ ngay.

Tắc hoặc nhiễm khuẩn: không cố thông bằng áp lực; báo bác sĩ, thay đường truyền và xử trí theo tình trạng. Nghi đứt catheter cần hỗ trợ chuyên môn, không thao tác mò tìm.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [9]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

16 LẤY NƯỚC TIỂU LÀM XÉT NGHIỆM NGƯỜI BỆNH CÓ ỐNG THÔNG TIỂU

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Lấy nước tiểu làm xét nghiệm trên người bệnh đã đặt ống thông tiểu là kỹ thuật lấy nước tiểu qua ống thông tiểu, nước tiểu lấy ra đảm bảo vô khuẩn, đúng nước tiểu trong bàng quang của người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

người bệnh đã đặt sonde tiểu có chỉ định lấy nước tiểu làm xét nghiệm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

4. THẬN TRỌNG

Giữ hệ thống dẫn lưu kín; chỉ lấy qua cổng lấy mẫu được thiết kế của hệ thống. Không lấy mẫu cấy từ túi, không chọc thủng dây dẫn hoặc nhánh bơm bóng [7].

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

02 điều dưỡng.

5.2. Thuốc

Dung dịch sát khuẩn tay và cổng lấy mẫu tương thích hệ thống; để khô theo sản phẩm.

5.3. Vật tư

Găng sạch : 01 đôi

Găng vô khuẩn : 01 đôi

Gạc vô trùng

Pen vô trùng

Bình kiềm

Lọ đựng bệnh phẩm

Mũ :01 cái

Khẩu trang : 01 cái

Bơm tiêm và đầu nối vô khuẩn phù hợp cổng lấy mẫu không kim; lọ bệnh phẩm, nhãn và dụng cụ vận chuyển đúng xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Thiết bị phù hợp đã kiểm tra hoạt động; phương tiện theo dõi và cấp cứu theo tình trạng.

5.5. Người bệnh

Thông báo giải thích cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh về việc sắp làm.

5.6. Hồ sơ bệnh án

phiếu chỉ định xét nghiệm.

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 05 phút – 10phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, phiếu xét nghiệm, loại mẫu và yêu cầu phòng xét nghiệm; chuẩn bị lọ vô khuẩn hoặc dụng cụ đúng xét nghiệm.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, mang găng. Xác định đúng cổng lấy mẫu không kim; nếu cần tích nước tiểu mới, kẹp ngắn theo hướng dẫn hệ thống và tình trạng người bệnh, không kẹp kéo dài.

6.3. Bước 3: Sát khuẩn cổng, để khô; hút mẫu bằng bơm tiêm và đầu nối vô khuẩn tương thích, không đâm kim vào dây tùy ý.

6.4. Bước 4: Chuyển mẫu vào lọ thích hợp, đóng kín, ghi hai thông tin định danh, giờ và nguồn mẫu. Tháo kẹp ngay nếu đã kẹp, kiểm tra dẫn lưu.

6.5. Bước 5: Gửi mẫu đúng thời gian và điều kiện phòng xét nghiệm; xử lý rác, sắc nhọn nếu có, vệ sinh tay và ghi nhận.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi độ thông và nước tiểu sau thao tác; bảo đảm đã tháo kẹp.

Rò hoặc tổn hại hệ thống: báo người phụ trách để xử lý và khôi phục hệ thống kín theo quy định. Mẫu nghi nhiễm bẩn hoặc sai định danh cần phối hợp lấy lại, không sửa nhãn theo suy đoán.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [7]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

17 CHO ĂN QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY (Có kiểm tra thể tích dịch tồn dư)

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Cho ăn qua ống thông dạ dày là một kỹ thuật nhằm mục đích đưa một lượng thức ăn (sữa, súp, các chất với mục đích dinh dưỡng) qua 1 ống thông được đặt từ mũi (hoặc miệng) qua thực quản vào dạ dày.

Có thể bơm nước hoặc các thuốc cần điều trị bệnh qua ống thông dạ dày.

Cũng có thể để dẫn lưu dịch từ dạ dày khi có chỉ định.

2. CHỈ ĐỊNH

2.1. người bệnh không thể ăn được:

người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, người bệnh đang thở máy.

người bệnh mất hoặc giảm khả năng bảo vệ đường thở, rối loạn nuốt, liệt thần kinh hầu họng do mọi nguyên nhân, hôn mê, co giật, tai biến mạch não…

người bệnh có bệnh lý đường tiêu hóa : liệt dạ dày, u thực quản chưa gây tắc nghẽn toàn bộ, tổn thương miệng…

2.2. người bệnh tự ăn ít, cần được cung cấp thêm dinh dưỡng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chưa xác nhận vị trí ống; tắc hoặc thiếu máu ruột; xuất huyết tiêu hóa nặng chưa kiểm soát; sốc chưa được kiểm soát hoặc các trường hợp bác sĩ chỉ định tạm ngừng nuôi ăn. Không dùng một ngưỡng dịch tồn dư thấp làm chống chỉ định tuyệt đối.

4. THẬN TRỌNG

Nguy cơ hít sặc, liệt dạ dày, hội chứng tái nuôi ăn, rối loạn điện giải và hạn chế dịch cần kế hoạch cá thể hóa. Bộ này áp dụng người lớn; không dùng lượng và ngưỡng của người lớn cho trẻ em.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng đã được đào tạo chuyên khoa Hồi sức cấp cứu.

5.2. Thuốc

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Xà phòng diệt khuẩn

5.3. Vật tư

Băng dính

Gạc vô trùng

Găng sạch : 01 đôi

Cốc sạch

Mũ : 01 cái

Khẩu trang : 01 cái

Thức ăn cho người bệnh theo chỉ định (chế độ bệnh lý hoặc sữa).

Bơm tiêm và đầu nối dành riêng đường ruột, que pH thích hợp nếu sử dụng, bộ nuôi ăn và nước theo chỉ định.

5.4. Trang thiết bị

Máy theo dõi nối với cáp điện tim

cáp đo SpO2

cáp đo huyết áp

5.5. Người bệnh

Giải thích; đánh giá nguy cơ hít sặc và dung nạp, nâng đầu 30–45 độ nếu không chống chỉ định; xác nhận vị trí ống trước sử dụng.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 15 phút – 20 phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, y lệnh dinh dưỡng, loại ống, vị trí, công thức, tốc độ và lượng nước. Xác nhận vị trí ban đầu bằng phương pháp phù hợp, như pH dịch hút 1–5,5 hoặc X-quang theo hướng dẫn; không dùng nghe tiếng bơm khí làm căn cứ duy nhất [10].

6.2. Bước 2: Trước mỗi lần dùng, kiểm tra vạch ngoài, cố định, dấu hiệu di lệch và xác nhận theo quy trình. Nếu chưa chắc vị trí, không cho ăn, nước hoặc thuốc, báo bác sĩ.

6.3. Bước 3: Vệ sinh tay, chuẩn bị công thức và dụng cụ đường ruột riêng; nâng đầu 30–45 độ nếu không chống chỉ định. Bảo đảm không nhầm đầu nối với đường tĩnh mạch.

6.4. Bước 4: Kiểm tra dịch tồn dư dạ dày khi có chỉ định hoặc quy định đã phê duyệt, không áp dụng cho ống sau môn vị như ống dạ dày. Đánh giá cùng nôn, chướng, đau và tình trạng toàn thân.

6.5. Bước 5: Không tự dừng nuôi ăn hoặc chuyển sang dinh dưỡng tĩnh mạch chỉ vì dịch tồn dư trên 100 hoặc 200 ml; không mặc định bỏ 80 ml dịch. Bác sĩ quyết định

ngưỡng can thiệp và việc bơm trả phù hợp. Hướng dẫn SCCM/ASPEN ở người lớn khuyến cáo không ngừng chỉ vì tồn dư dưới 500 ml khi không có dấu không dung nạp khác [11].

6.6. Bước 6: Cho ăn ngắt quãng hoặc liên tục với lượng và tốc độ theo y lệnh, theo dõi dung nạp; không áp dụng một tốc độ cố định cho mọi người bệnh. Bơm nước trước, sau và giữa thuốc theo chỉ định, giới hạn dịch và thiết bị.

6.7. Bước 7: Kết thúc, duy trì tư thế phù hợp, ghi lượng ăn, nước, dịch tồn dư nếu đo, dung nạp và bất thường; bảo quản và xử lý bộ nuôi ăn đúng quy định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi nôn, trào ngược, đau, chướng bụng, phân, đường huyết, cân bằng dịch và điện giải khi có chỉ định.

Nghi di lệch hoặc hít sặc: ngừng nuôi ăn, gọi bác sĩ, đánh giá và hỗ trợ đường thở, xác minh vị trí trước dùng lại.

Ống tắc: kiểm tra nguyên nhân, xử trí theo quy trình đường ruột; không cố bơm áp lực hoặc dùng vật nhọn. Rối loạn điện giải và nghi tái nuôi ăn cần bác sĩ điều chỉnh chế độ.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [10], [11]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

18 CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG ĐẶC BIỆT

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Giữ răng miệng luôn sạch để phòng nhiễm khuẩn răng miệng.

Chống nhiễm trùng trong trường hợp có tổn thương ở miệng.

Giảm nguy cơ viêm phổi ở người bệnh có đặt nội khí quản (mở khí quản).

Giúp người bệnh thoải mái dễ chịu ăn ngon.

2. CHỈ ĐỊNH

Đối với người bệnh có chỉ định chăm sóc cấp I.

người bệnh hôn mê, người bệnh có đặt ống nội khí quản- mở khí quản.

người bệnh không thể tự vệ sinh răng miệng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Đánh giá răng lung lay, răng giả, chấn thương miệng, nguy cơ chảy máu và hít sặc. Không dùng lực để cạy miệng hoặc lấy răng làm điểm tựa; kiểm soát lượng dịch và hút liên tục khi cần.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

01 điều dưỡng đã được đào tạo chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

5.2. Thuốc

Dung dịch súc miệng

Natriclorua 0,9% l

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Xà phòng rửa tay diệt khuẩn

5.3. Vật tư

Găng sạch

Khay hạt đậu

Que đè lưỡi

Ống hút đờm

Bơm tiêm 20ml : 01 cái

Bơm tiêm 10ml : 01 cái

Dây hút dịch

Bàn chải đánh răng loại nhỏ

Cốc đựng nước

Túi nilon đựng đồ bẩn

Canuyn mở miệng

Kem đánh răng

Khăn bông nhỏ

Gạc

Pen không mấu

Khay chữ nhật

Mũ : 01 cái

Khẩu trang : 01 cái

Bóng Ambu

mặt nạ bóp bóng.

Bộ dụng cụ đặt ống nội khí quản

mở khí quản cấp cứu.

Kim lấy thuốc : 01 cái

5.4. Trang thiết bị

Máy theo dõi

máy SpO2

máy đo huyết áp

5.5. Người bệnh

người bệnh nằm ngửa đầu cao 30°, đầu nghiêng một bên đối với người bệnh hôn mê.

Giải thích động viên người bệnh hoặc gia đình người bệnh về việc sắp làm.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 10 phút – 15 phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Thông báo giải thích cho người bệnh hoặc người nhà về mục đích của việc vệ sinh răng miệng.

6.2. Bước 2: Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.

6.3. Bước 3: Làm ướt bàn chải đánh răng, lấy kem đánh răng.

6.4. Bước 4: Đổ dung dịch Nacl 0,9%, hoặc dung dịch súc miệng.

6.5. Bước 5: Kiểm tra áp lực cuff nội khí quản (mở khí quản) nếu có.

6.6. Bước 6: Trải khăn bông dưới cằm, má.

6.7. Bước 7: Đặt người bệnh quay mặt về phía điều dưỡng.

6.8. Bước 8 : Đặt khay hạt đậu cạnh má.

6.9. Bước 9: Mở miệng người bệnh, tháo răng giả nếu có.

6.10. Bước 10: Đánh răng cho người bệnh lần lượt các mặt răng: ngoài, trong, nhai.

6.11. Bước 11: Dùng dây hút dung dịch súc miệng. Chỉ dùng lượng dịch nhỏ phù hợp và hút để hạn chế hít sặc, không bơm rửa ồ ạt. Với người bệnh không có răng hoặc có chấn thương vùng miệng, xương hàm. Vệ sinh miệng cho người bệnh bằng gạc củ ấu với dung dịch súc miệng.

6.12. Bước 12 : Lau khô miệng cho người bệnh

6.13. Bước 13: Đặt người bệnh tư thế thích hợp.

6.14. Bước14 : Thu dọn dung cụ, rửa tay.

6.15. Bước 15: Ghi hồ sơ bệnh án hoặc bảng theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi niêm mạc, chảy máu, đau, SpO2, vị trí ống và khả năng dung nạp.

Nghi sặc hoặc dị vật đường thở: dừng chăm sóc, hút dịch trong miệng, đánh giá đường thở và gọi bác sĩ; hỗ trợ hô hấp theo tình trạng.

Chảy máu hoặc tổn thương: dừng thao tác gây tổn thương, báo bác sĩ khi cần; điều chỉnh dụng cụ và kế hoạch chăm sóc. Không dùng chlorhexidine thường quy chỉ nhằm dự phòng viêm phổi nếu chưa có chỉ định và quy trình phù hợp.

Ghi thời điểm, nhận định, thao tác, đáp ứng, tai biến và xử trí; báo và bàn giao bất thường cho bác sĩ, ca trực tiếp theo. Nếu có biến cố đe dọa tính mạng, gọi hỗ trợ và ưu tiên cấp cứu theo quy trình bệnh viện.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

19 GỌI ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỌC

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Làm sạch tóc và da đầu cho người bệnh. Giúp người bệnh thoái mái, dễ chịu.

Phòng chống các bệnh về tóc và da đầu, đồng thời kích thích tuần hoàn cho người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh không tự gội đầu được, có nhu cầu vệ sinh và tình trạng cho phép. Nhiễm hóa chất hoặc chất độc cần quy trình khử nhiễm riêng, không mặc định dùng cách gội thông thường.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Hoãn gội tại giường khi huyết động hoặc hô hấp không ổn định; chấn thương sọ não hoặc cột sống cổ chưa đánh giá an toàn tư thế. Sốt đơn thuần không phải chống chỉ định tuyệt đối.

4. THẬN TRỌNG

Giữ ấm, tránh nước vào mắt, tai và đường thở; bảo vệ đường truyền, dẫn lưu và dây máy thở. Không xoay cổ khi chưa được phép; tránh thiết bị điện gần nước hoặc nguồn oxy.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng đã được đào tạo chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

hoặc Người thực hiện phụ chăm sóc đã được đào tạo.

5.2. Thuốc

Dung dịch sát khuẩn phù hợp

Dung dịch khuẩn tay nhanh

Xà phòng rửa tay diệt khuẩn

5.3. Vật tư

Găng sạch : 01 đôi

Thùng đựng nước sạch

Thau gội đầu

Thùng đựng nước bẩn

Ca múc nước

Khăn bông to

Khăn bông nhỏ

Lược chải đầu

Bông không thâm nước

Dầu gội đầu

Ga đắp

Quần áo

Nước ấm 30-37 độ

Mũ : 01 cái

Khẩu trang : 01 cái

5.4. Trang thiết bị

Thiết bị phù hợp đã kiểm tra hoạt động; phương tiện theo dõi và cấp cứu theo tình trạng.

5.5. Người bệnh

Kiểm tra ý thức người bệnh, đo dấu hiệu sinh tồn cho người bệnh.

Thông báo , giải thích cho người bệnh hoặc người nhà về việc chuẩn bị làm.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 15 phút - 30phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Động viên người bệnh hợp tác cùng làm việc (nếu người bệnh tỉnh).

6.2. Bước 2: Người thực hiện rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước , đội mũ, đeo khẩu trang.

6.3. Bước 3: Kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp cho người bệnh.

6.4. Bước 4: Mang dụng cụ đã chẩn bị đến giường bệnh .

6.5. Bước 5: Đặt tư thế người bệnh trên giường thích hợp. chú ý hệ thống dây của máy

thở và các dây máy theo dõi.

6.6. Bước 6: Trải khăn bông to ở dưới vai, gáy.

6.7. Bước 7: Đặt thau gội đầu.

6.8. Bước 8: Đặt đầu người bệnh vào thau.

6.9. Bước 9: Choàng khăn bông lên ngực người bệnh hoặc đắp ga kín ngực.

6.10. Bước 10: Chải tóc người bệnh nhẹ nhàng từ ngọn tóc đến chân tóc.

6.11. Bước 11: Đặt bông không thấm nước vào tai người bệnh.

6.12. Bước 12: Đi găng sạch(nếu cần)

6.13. Bước 13: Dội nước làm ướt tóc, xoa dầu gội, chà xát da đầu bằng các đầu ngón tay (1 tay đỡ đầu, 1 tay chà đầu, tránh làm xây xát da đầu, lắc đầu người bệnh).

6.14. Bước 14: Dội nước cho đến khi sạch dầu gội đầu (chú ý không để nước vào tai,mắt người bệnh)

6.15. Bước 15: Bỏ bông tai, lấy khăn bông nhỏ lau mặt, tai, cổ cho người bệnh.

6.16. Bước 16: Kéo khăn choàng lau tóc, bỏ thau gội đầu.

6.17. Bước 17: Cho người bệnh nằm tư thế thoải mái, lau khô tóc bằng khăn, chải tóc, buộc tóc gọn gàng.

6.18. Bước 18: Thay ga trải giường (nếu cần)

6.19. Bước 19: Thu dọn dụng cụ, cất dụng cụ đúng nơi quy định

6.20. Bước 20: Người thực hiện rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước.

6.21. Bước 21: Ghi bảng theo dõi.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi SpO2, ý thức, nhịp thở, mạch và dung nạp. Dừng khi khó thở, tụt SpO2 hoặc huyết động thay đổi, gọi hỗ trợ.

Hạ thân nhiệt: lau khô, giữ ấm và đánh giá sinh hiệu. Theo dõi da đầu, đường truyền và đường thở sau thực hiện.

Ghi thời điểm, nhận định, thao tác, đáp ứng, tai biến và xử trí; báo và bàn giao bất thường cho bác sĩ, ca trực tiếp theo. Nếu có biến cố đe dọa tính mạng, gọi hỗ trợ và ưu tiên cấp cứu theo quy trình bệnh viện.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

20 THỬ ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Theo dõi diễn biến lượng đường trong máu của người bệnh bằng máy thử và

que thử. Gúp bác sỹ kiểm soát và điều trị đạt kết quả tốt cho người bệnh, nhất là những người bệnh bi tiểu đường và rối loạn điện giải.

2. CHỈ ĐỊNH

Theo dõi hoặc nghi rối loạn đường huyết: đái tháo đường, điều trị insulin, hạ đường huyết, rối loạn ý thức, bệnh nặng và chỉ định khác. Không giới hạn chỉ cho người đã chẩn đoán đái tháo đường.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối khi cần đánh giá đường huyết. Chọn vị trí khác hoặc mẫu xét nghiệm khác nếu vùng lấy bị tổn thương, tưới máu kém hoặc kết quả mao mạch không đáng tin.

4. THẬN TRỌNG

Trong sốc, tưới máu ngoại vi kém hoặc khi kết quả không phù hợp lâm sàng, lấy mẫu tĩnh mạch hoặc động mạch xác nhận theo chỉ định. Không trì hoãn xử trí cấp cứu hạ đường huyết chỉ để chờ xét nghiệm. Dùng máy chuyên dụng phù hợp và kiểm soát chất lượng [12].

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng.

5.2. Thuốc

Dung dịch sát khuẩn phù hợp

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Xà phòng rửa tay diệt khuẩn

5.3. Vật tư

Que thử

Bông vô khuẩn

Pen

Găng sạch : 01 đôi

Bình kiềm

Mũ : 01 cái

Khẩu trang : 01 cái

Kim chích an toàn tự vô hiệu hóa dùng một lần, que thử đúng máy, gạc, hộp sắc nhọn.

5.4. Trang thiết bị

Máy thử

5.5. Người bệnh

Thông báo giải thích cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh về việc sắp làm.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 03 phút - 05phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, kiểm tra chỉ định và thời điểm lấy mẫu; kiểm tra máy, chất lượng, hạn que, bảo quản và đơn vị hiển thị.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, mang găng; chọn vị trí phù hợp, làm sạch và để khô theo hướng dẫn. Sử dụng kim chích an toàn dùng một lần, không dùng chung thiết bị chích [12].

6.3. Bước 3: Chích và lấy giọt máu đúng hướng dẫn máy, không bóp mạnh ngón tay. Đưa mẫu vào que đúng trình tự và đủ lượng; chờ kết quả theo thiết bị, không mặc định 10 giây.

6.4. Bước 4: Ép nhẹ điểm chích bằng gạc, thải kim ngay vào hộp sắc nhọn và que vào chất thải phù hợp; làm sạch máy giữa người bệnh bằng sản phẩm tương thích.

6.5. Bước 5: Ghi kết quả, đơn vị mmol/l hoặc mg/dl, thời điểm, liên quan bữa ăn và thuốc; báo ngay kết quả bất thường hoặc LO/HI và đánh giá người bệnh.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi điểm chích và biểu hiện rối loạn đường huyết.

Kết quả nghi sai: kiểm tra máy, que và kỹ thuật, xác nhận bằng xét nghiệm phù hợp. Không tự suy đoán trị số khi máy báo LO/HI.

Có triệu chứng nặng hoặc đường huyết nguy hiểm: báo bác sĩ, xử trí theo phác đồ của bệnh viện và theo dõi lại theo chỉ định.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [12]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

21 TRUYỀN THUỐC BẰNG BƠM TIÊM ĐIỆN

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Là quy trình thường xuyên áp dụng trong khoa hồi sức cấp cứu.

Áp dụng cho các thuốc cần đưa liều một cách chính xác và liên tục.

2. CHỈ ĐỊNH

Truyền thuốc cần kiểm soát tốc độ và liều chính xác, liên tục hoặc theo thời gian, với đường dùng và bơm tiêm tương thích theo y lệnh.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định của thuốc hoặc đường dùng; không sử dụng khi máy, bơm tiêm hoặc hệ dây không tương thích, hỏng hoặc chưa đủ điều kiện an toàn.

4. THẬN TRỌNG

Người thao tác phải được đào tạo đúng model thiết bị. Thuốc nguy cơ cao cần kiểm tra độc lập theo quy định bệnh viện: thuốc, nồng độ, liều, cân nặng khi dùng, đơn vị và tốc độ. Không coi tên phím hoặc màu đèn của một máy là đúng cho mọi máy.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng đã được đào tạo chuyên khoa hồi sức cấp cứu.

5.2. Thuốc

Thuốc, dịch và dung môi đúng y lệnh, nồng độ và tương hợp; nhãn thuốc và thông tin liều đầy đủ.

Dung dịch sát khuẩn phù hợp

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Xà phòng diệt khuẩn

5.3. Vật tư

Bơm tiêm 50ml: 01 cái

Dây nối bơm tiêm điện: 01 cái

Khóa 3 chia: 01 cái

Pen vô khuẩn

Găng sạch

Khay hạt đậu

Khay chữ nhật

Kéo

Bình kiềm

Hộp chống sốc

Gòn

Mũ: 01 cái

Khẩu trang: 01 cái.

Hộp chống sốc gồm đầy đủ thuốc theo quy định.

5.4. Trang thiết bị

Cọc truyền

Bơm tiêm điện

5.5. Người bệnh

Thông báo và giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh về việc sắp làm.

Đặt người bệnh tư thế thích hợp.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 05 phút - 10phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, đối chiếu y lệnh, dị ứng, thuốc, liều và đường truyền; tính và kiểm tra nồng độ, tốc độ ml/giờ và liều theo thời gian nếu có.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, pha thuốc vô khuẩn và dán nhãn đầy đủ. Chọn bơm tiêm đúng loại, cỡ tương thích; lắp dây, đuổi khí ngoài người bệnh, không dùng chức năng prime hoặc bolus khi đã nối vào người bệnh.

6.3. Bước 3: Kiểm tra máy, nguồn điện, pin, cảnh báo và hạn bảo trì; gắn chắc lên cọc. Lắp bơm tiêm, kẹp thân và pít-tông đúng hướng dẫn; xác nhận máy nhận đúng cỡ.

6.4. Bước 4: Cài tốc độ, đơn vị và giới hạn liên quan theo y lệnh; kiểm tra độc lập với thuốc nguy cơ cao. Kiểm tra nhánh truyền, tương hợp thuốc và đầu nối trước kết nối.

6.5. Bước 5: Sát khuẩn đầu nối, để khô, kết nối và khởi động đúng model; xác nhận máy chạy, không rò và thông số đúng. Không thao tác bolus ngoài y lệnh.

6.6. Bước 6: Ghi thuốc, nồng độ, tốc độ, giờ bắt đầu và đường truyền; dự trù đổi bơm tiêm để không gián đoạn thuốc thiết yếu, bàn giao rõ.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi người bệnh, vị trí truyền, lượng và tốc độ thực truyền, nguồn điện, pin và báo động; đánh giá tính phù hợp giữa màn hình và lâm sàng.

Báo tắc: kiểm tra dây, kẹp và vị trí; không cố bơm rửa hoặc giải phóng áp lực gây bolus. Xử trí áp lực tồn theo hướng dẫn máy trước nối hoặc khởi động lại.

Báo khí, hết dịch, pin yếu hoặc lỗi máy: đánh giá người bệnh và dòng thuốc, khắc phục theo model hoặc chuyển sang thiết bị dự phòng đã kiểm tra, tránh gián đoạn thuốc thiết yếu.

Nghi thoát mạch, phản ứng thuốc hoặc quá tải: ngừng tác nhân theo tình trạng, gọi bác sĩ và thực hiện phác đồ. Hỏng cảm biến hoặc pin cần bộ phận thiết bị y tế, không tự thay linh kiện ngoài năng lực.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

22 TRUYỀN DỊCH BẰNG MÁY TRUYỀN DỊCH

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Máy truyền dịch kiểm soát tốc độ và thể tích trong giới hạn được nhà sản xuất quy định. Không mặc định mọi máy truyền dịch là phương tiện truyền nhanh lượng lớn trong hồi sức.

2. CHỈ ĐỊNH

Kiểm soát lượng dịch truyền vào cơ thể người bệnh.

Duy trì đường truyền với tốc độ thấp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định của loại dịch, thuốc hoặc đường truyền; không dùng máy hoặc bộ dây không tương thích, hỏng hay chưa đủ điều kiện an toàn.

4. THẬN TRỌNG

Người thao tác phải được đào tạo đúng model thiết bị. Thuốc nguy cơ cao cần kiểm tra độc lập theo quy định bệnh viện: thuốc, nồng độ, liều, cân nặng khi dùng, đơn vị và tốc độ. Không coi tên phím hoặc màu đèn của một máy là đúng cho mọi máy.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

điều dưỡng đã được đào tạo chuyên khoa hồi sức cấp cứu.

5.2. Thuốc

Thuốc, dịch và dung môi đúng y lệnh, nồng độ và tương hợp; nhãn thuốc và thông tin liều đầy đủ.

Dung dịch sát khuẩn phù hợp

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Xà phòng diệt khuẩn.

5.3. Vật tư

Khóa 3 chia: 01 cái.

Pen vô khuẩn

Găng sạch: 01 đôi.

Khay hạt đậu

Khay chữ nhật

Kéo

Bình kiềm

Hộp chống sốc

Gòn khô

Mũ: 01 cái

Khẩu trang: 01 cái

Hộp chống sốc gồm đầy đủ thuốc theo quy định.

Dây truyền máy: 01 cái

5.4. Trang thiết bị

Máy truyền dịch

Cọc truyền

5.5. Người bệnh

thông báo và giải thích cho người bệnh và gia đình việc sắp làm.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 05 phút - 10phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, kiểm tra y lệnh, loại dịch, thuốc pha, tương hợp, tổng lượng, tốc độ, đường truyền và hạn dùng.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, chuẩn bị dịch và bộ dây được nhà sản xuất xác nhận tương thích; đuổi khí ngoài người bệnh và dán nhãn đầy đủ.

6.3. Bước 3: Kiểm tra máy, điện và pin; lắp dây đúng model với kẹp kiểm soát dòng chảy. Phòng chảy tự do: kẹp dây trước khi mở cửa hoặc tháo dây.

6.4. Bước 4: Cài tốc độ ml/giờ, thể tích dự kiến truyền và các giới hạn theo y lệnh; kiểm tra độc lập khi có thuốc nguy cơ cao.

6.5. Bước 5: Sát khuẩn đầu nối, để khô, kết nối và khởi động; xác nhận dòng truyền và thông số, quan sát vị trí truyền và đáp ứng.

6.6. Bước 6: Kết thúc đúng thể tích hoặc y lệnh; không tự tăng thể tích cài đặt để tiếp tục. Đổi chai hoặc bộ dây theo kế hoạch; duy trì liên tục thuốc thiết yếu khi chuyển máy.

6.7. Bước 7: Ghi dịch, thuốc, thể tích thực truyền, tốc độ, thời gian và bất thường; bàn giao lượng còn lại và kế hoạch tiếp tục.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi người bệnh, vị trí truyền, lượng và tốc độ thực truyền, nguồn điện, pin và báo động; đánh giá tính phù hợp giữa màn hình và lâm sàng.

Báo tắc: kiểm tra dây, kẹp và vị trí; không cố bơm rửa hoặc giải phóng áp lực gây bolus. Xử trí áp lực tồn theo hướng dẫn máy trước nối hoặc khởi động lại.

Báo khí, hết dịch, pin yếu hoặc lỗi máy: đánh giá người bệnh và dòng thuốc, khắc phục theo model hoặc chuyển sang thiết bị dự phòng đã kiểm tra, tránh gián đoạn thuốc thiết yếu.

Nghi thoát mạch, phản ứng thuốc hoặc quá tải: ngừng tác nhân theo tình trạng, gọi bác sĩ và thực hiện phác đồ. Hỏng cảm biến hoặc pin cần bộ phận thiết bị y tế, không tự thay linh kiện ngoài năng lực.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

23 SỬ DỤNG MÁY MONITOR

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Monitor theo dõi bệnh nhân là một thiết bị đo lường và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân, có thể theo dõi các chỉ số như đo nhịp tim, huyết áp, và các chỉ số khác của cơ thể.

2. CHỈ ĐỊNH

Áp dụng cho tất cả người bệnh tại khoa hồi sức cấp cứu cần theo dõi dấu hiệu sinh tồn , nhịp tim… để phát hiện các dấu hiệu bất thường.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Vị trí dán điện cực bị nhiễm trùng , tổn thương.

Không có chống chỉ định tuyệt đối.

4. THẬN TRỌNG

Monitor hỗ trợ theo dõi, không thay thế đánh giá người bệnh. Cài ngưỡng báo động và chu kỳ đo theo tình trạng, không vô hiệu hóa cảnh báo để bỏ qua bất thường.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

1 điều dưỡng: rửa tay, đội mũ , đeo khẩu trang.

5.2. Thuốc

Sát khuẩn tay nhanh hoặc xà phòng

Các chất dẫn điện (gel) hoặc nước muối sinh lý 0,9%. (nếu cần)

5.3. Vật tư

Túi đựng đồ bẩn : 01 cái .

Khay hạt đậu: 01 cái .

Miếng dán điện cực

có đủ dây dẫn và bản điện cực.

Bông gạc để lau bẩn trên da người bệnh trước khi gắn điện cực và lau chất dẫn điện sau khi ghi điện tim.

5.4. Trang thiết bị

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Ổ điện

5.5. Người bệnh

Thông báo, giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh tỉnh).

Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 05 phút - 10phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, giải thích, kiểm tra chỉ định và thông số cần theo dõi; kiểm tra model máy, điện, pin, dây và phụ kiện.

6.2. Bước 2: Làm sạch da, gắn điện cực theo ký hiệu RA, LA, RL, LL và V của hệ thống, đúng sơ đồ nhà sản xuất; không suy đoán vị trí chỉ theo màu vì hệ AHA và IEC khác nhau.

6.3. Bước 3: Chọn vị trí điện cực ngực theo chuyển đạo muốn theo dõi; theo dõi điện tim trên monitor không thay thế điện tâm đồ 12 chuyển đạo khi có chỉ định.

6.4. Bước 4: Chọn băng huyết áp đúng cỡ, đặt trên chi phù hợp, tránh chi có đường thông động tĩnh mạch, tổn thương hoặc chống chỉ định; đặt chu kỳ đo theo y lệnh.

6.5. Bước 5: Gắn cảm biến SpO2 đúng cỡ và vị trí, đánh giá tưới máu và chất lượng tín hiệu; so sánh nhịp hiển thị với mạch thực khi nghi sai.

6.6. Bước 6: Cài báo động, kiểm tra tín hiệu, ghi sinh hiệu và tình trạng người bệnh; đánh dấu những giá trị không tin cậy, bàn giao giới hạn và chu kỳ đo.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Khi báo động, đánh giá người bệnh trước, kiểm tra mạch, hô hấp, ý thức và huyết động; xử trí cấp cứu khi cần, sau đó kiểm tra điện cực và phụ kiện.

Theo dõi kích ứng da, tì đè từ cảm biến hoặc băng huyết áp; đổi vị trí phù hợp và chăm sóc da.

Nghi đo sai do cử động, tưới máu kém hoặc lỗi máy: kiểm tra bằng phương pháp khác, báo bác sĩ khi bất thường; không kết luận người bệnh ổn chỉ vì màn hình bình thường.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

24 ĐO ĐIỆN TÂM ĐỒ 12 CHUYỂN ĐẠO TẠI CHỖ

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

Điện tâm đồ là hình ảnh hoạt động điện học của tim được ghi lại dưới dạng đồ thị qua các điện cực tiếp nhận ngoài da.

2. CHỈ ĐỊNH

Chẩn đoán rối loạn nhịp tim.

Chẩn đoán phì đại cơ nhĩ, cơ thất.

Chẩn đoán rối loạn dẫn truyền.

Chẩn đoán các giai đoạn nhồi máu cơ tim.

Chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Chẩn đoán các rối loạn điện giải.

Chẩn đoán các tổn thương ở cơ tim, màng ngoài tim.

Theo dõi máy tạo nhịp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

4. THẬN TRỌNG

Kiểm tra vị trí điện cực, nhãn và cài đặt trước ghi; nhiễu hoặc đặt sai có thể gây chẩn đoán nhầm. Giải thích và hỗ trợ người bệnh nằm yên, không an thần thường quy chỉ vì lo lắng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

01 kỹ thuật viên hoặc điều dưỡng.

01 bác sĩ.

5.2. Thuốc

Các chất dẫn điện (gel) hoặc nước muối sinh lý 0,9%.

5.3. Vật tư

Bông gạc để lau bẩn trên da người bệnh trước khi gắn điện cực và lau chất dẫn điện

Giấy dán kết quả điện tâm đồ. (nếu cần)

10 điện cực, giấy in và vật tư tương thích để ghi đủ 12 chuyển đạo.

5.4. Trang thiết bị

Máy điện tâm đồ có đủ dây dẫn và bản điện cực.

Có hệ thống chống nhiễu tốt.

5.5. Người bệnh

Giải thích cho người bệnh về cách tiến hành kỹ thuật.

Nằm yên tĩnh, không cử động.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Bệnh án cần được hoàn thiện đầy đủ thủ tục hành chính, ghi nhận xét trong quá trình khám, điều trị và ghi y lệnh đầy đủ theo quy chế bệnh án.

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

10-20 phút

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, kiểm tra chỉ định, giải thích và giữ riêng tư; cho người bệnh nghỉ, nằm tư thế thích hợp, bộc lộ và làm sạch vị trí điện cực.

6.2. Bước 2: Đặt 4 điện cực chi và 6 điện cực ngực để ghi 12 chuyển đạo. V1: khoang liên sườn 4 bờ phải ức; V2: khoang liên sườn 4 bờ trái ức; V4: khoang liên sườn 5 đường giữa đòn trái; V3: giữa V2 và V4; V5: đường nách trước trái, V6: đường nách giữa trái, cùng mức ngang V4.

6.3. Bước 3: Kiểm tra dây và tiếp xúc; ghi tiêu chuẩn 25 mm/giây, biên độ 10 mm/mV. Nếu dùng cài đặt khác hoặc vị trí thay thế, ghi rõ trên bản điện tâm đồ.

6.4. Bước 4: Kiểm tra chất lượng đủ 12 chuyển đạo, nhãn định danh, thời gian và hiệu chuẩn; xử lý nhiễu, ghi lại nếu cần. Chuyển bác sĩ đọc và kết luận, không coi kết luận tự động là chẩn đoán cuối.

6.5. Bước 5: Tháo điện cực, làm sạch da và dụng cụ, ghi thực hiện. Báo bác sĩ ngay khi có triệu chứng cấp hoặc nghi biến đổi nguy hiểm, không chờ hoàn tất giấy tờ.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi triệu chứng và khả năng dung nạp trong ghi.

Kích ứng da: làm sạch, đổi loại điện cực hoặc vị trí phù hợp và ghi nhận. Nhiễu hoặc nghi sai vị trí: kiểm tra, ghi lại, ghi rõ điều chỉnh.

Người bệnh đau ngực, khó thở, ngất hoặc huyết động không ổn định: gọi hỗ trợ và xử trí theo quy trình cấp cứu; không trì hoãn để ghi điện tâm đồ hoàn hảo.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [16]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

25 HÚT ĐỜM CHO NGƯỜI BỆNH CÓ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN, MỞ KHÍ QUẢN

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

- Hút đờm là một kỹ thuật đưa ống thông qua ống nội khí quản, mở khí quản hút sạch đờm trong ống nội khí quản, mở khí quản và trong khí quản của người bệnh.

- Là một kỹ thuật rất cơ bản trong hồi sức cấp cứu nhằm khai thông và kiểm soát đường thở người bệnh đã đặt ống nội khí quản, mở khí quản.

- Mục đích hút đờm:

+ Làm sạch dịch tiết để khai thông đường thở, duy trì sự thông thoáng.

+ Lấy dịch tiết phục vụ cho các mục đích chuẩn đoán.

+ Phòng nhiễm khuẩn và xẹp phổi do ứ đọng đờm.

+ Kích thích phản xạ ho.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có NKQ hoặc MKQ bị ứ đọng đờm, ho không hiệu quả, dấu hiệu tắc hoặc thay đổi thông khí có liên quan đờm. Không hút đường thở thường quy cho mọi trẻ sơ sinh; bộ này áp dụng người lớn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối khi cần giải phóng đường thở. Đánh giá lợi ích và nguy cơ ở người bệnh giảm oxy máu nặng, huyết động không ổn định hoặc dễ loạn nhịp. Chọn hệ thống tương thích ống và phương thức thở.

4. THẬN TRỌNG

Hút có thể gây giảm oxy máu, tổn thương niêm mạc, loạn nhịp và tăng áp lực nội sọ. Cần nhân viên được đào tạo, phương tiện cấp cứu và theo dõi liên tục [4].

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

02 điều dưỡng đã được đào tạo khi tình trạng cần hỗ trợ: một người hút, một người theo dõi và hỗ trợ; không bắt buộc vỗ rung hoặc đổi đủ ba tư thế.

5.2. Thuốc

Dung dịch sát khuẩn tay; dung dịch rửa catheter theo hướng dẫn bộ hút, chỉ dùng tại buồng rửa khi catheter đã rút hoàn toàn, không bơm thường quy vào đường thở.

5.3. Vật tư

Dây hút silicon

Ống hút đờm kích cỡ phù hợp:

Găng vô khuẩn : 01 đôi

Gạc vô khuẩn : 01 gói

Bơm tiêm 10ml : 02 cái

Găng sạch : 01 đôi

Mũ : 02 cái

Khẩu trang : 02 cái

Bao đo huyết áp

Ống nghe

Bóng Ambu

mặt nạ bóp bóng.

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản cấp cứu

Xô đựng dung dịch khử khuẩn

Catheter hút chọn theo ống đường thở của người lớn; loại vô khuẩn dùng một lần khi hút mở, hoặc hệ hút kín tương thích khi hút kín; dụng cụ hút miệng riêng.

5.4. Trang thiết bị

Máy hút áp lực âm có thể điều chỉnh mức áp lực:

Máy theo dõi

Cáp điện tim

Cáp đo SpO2

Cáp đo huyết áp liên tục

5.5. Người bệnh

- Thông báo giải thích động viên, vỗ rung cho người bệnh (nếu cần).

- Đặt người bệnh tư thế thích hợp.

Đánh giá nhu cầu tiền oxy hóa và dung nạp theo tình trạng; không áp dụng FiO2 100% kéo dài thường quy.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

trung bình 15phút - 30phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Kiểm tra định danh, chỉ định hút do ứ đọng đờm, thông khí giảm hoặc dấu hiệu tắc; đánh giá SpO2, nhịp tim, huyết động và thông số máy thở.

6.2. Bước 2: Vệ sinh tay, mang phòng hộ; chọn catheter có đường kính ngoài dưới 50% đường kính trong ống ở người lớn. Đặt áp lực âm thấp nhất có hiệu quả, đúng thiết bị; có thể khởi đầu 80–120 mmHg theo tình trạng, không lấy mức tối đa làm áp lực mặc định.

6.3. Bước 3: Tiền oxy hóa theo đánh giá và phương thức thở, theo dõi đáp ứng; tránh ngắt hỗ trợ hô hấp không cần thiết. Không áp dụng tự động FiO2 100% kéo dài cho mọi người bệnh.

6.4. Bước 4: Hút nông trước, đưa catheter tới chiều sâu đã xác định theo chiều dài ống, không hút khi đưa vào, không cố tiến tới sức cản hoặc carina. Hút sâu chỉ cân nhắc khi hút nông không hiệu quả và có đánh giá phù hợp.

6.5. Bước 5: Áp dụng hút trong khi rút nhẹ catheter, mỗi lượt tối đa 15 giây. Cho người bệnh hồi phục oxy hóa giữa các lượt; chỉ lặp lại khi còn chỉ định và người bệnh dung nạp, không bắt buộc hút đủ ba tư thế.

6.6. Bước 6: Không nhỏ NaCl 0,9% hoặc NaHCO3 thường quy vào đường thở. Dừng ngay khi giảm oxy máu đáng kể, nhịp chậm hoặc loạn nhịp, đau hoặc suy giảm huyết động; không chờ mạch dưới 40 lần/phút mới dừng.

6.7. Bước 7: Hút mở: duy trì vô khuẩn catheter và tay thao tác; giảm tối đa thời gian ngắt máy. Dùng catheter vô khuẩn một lần, thải bỏ sau sử dụng; không ngâm để tái dùng. Dụng cụ hút miệng riêng, không đưa vào đường thở dưới.

6.8. Bước 8: Kết thúc, khôi phục thông số oxy theo chỉ định khi ổn định; đánh giá đáp ứng, thu dọn, vệ sinh tay và ghi số lượt, tính chất đờm, SpO2 và biến cố.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi SpO2, nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, áp lực đường thở và đáp ứng trước, trong, sau hút. Hút theo chỉ định lâm sàng, không chỉ theo lịch cố định.

Giảm oxy máu, loạn nhịp hoặc suy giảm huyết động: dừng hút, hỗ trợ oxy hóa và thông khí, gọi bác sĩ; xử trí cấp cứu nếu ngừng tuần hoàn.

Chảy máu, tổn thương niêm mạc, co thắt, tăng áp lực nội sọ hoặc nghi nhiễm khuẩn: dừng hoặc điều chỉnh thao tác, báo bác sĩ đánh giá và thực hiện chỉ định. Bảo đảm vô khuẩn khi hút mở [4].

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [4]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

26 ĐO ÁP LỰC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM BẰNG CỘT NƯỚC (THƯỚC ĐO ÁP LỰC)

Phạm vi người lớn; thực hiện theo chỉ định, phân công và hướng dẫn thiết bị đã được bệnh viện phê duyệt.

1. ĐẠI CƯƠNG

CVP là áp lực tĩnh mạch trung tâm, chịu ảnh hưởng bởi áp lực lồng ngực, chức năng tim phải, tư thế và thông khí. Theo dõi xu hướng trong bối cảnh lâm sàng; không coi một khoảng trị số là bình thường cho mọi người bệnh hoặc là căn cứ duy nhất bù dịch [13].

2. CHỈ ĐỊNH

Theo dõi huyết động theo chỉ định ở người bệnh đã có catheter trung tâm phù hợp, dùng cùng dấu hiệu tưới máu và các đánh giá khác. Không dùng CVP đơn độc để quyết định bù dịch hoặc thuốc vận mạch.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định

4. THẬN TRỌNG

Không ngắt máy thở để đo CVP và không trừ số PEEP khỏi CVP theo công thức tùy ý. Không ngừng thuốc vận mạch để lấy nhánh đo; chọn nhánh phù hợp, tránh bolus, khí lọt và nhiễm khuẩn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

01 người: Bác sĩ hoặc điều dưỡng; đội mũ, đeo khẩu trang, rửa tay vô khuẩn

5.2. Thuốc

Dung dịch đẳng trương được chỉ định cho hệ đo; sản phẩm sát khuẩn tay và đầu nối phù hợp.

5.3. Vật tư

Dây truyền dịch

Chai dịch đẳng trương

Bơm tiêm 20ml

Khóa ba chạc (chạc ba)

Găng tay sạch

găng tay vô khuẩn

Khay tiêm truyền

Dây có đầu nối đo áp lực tĩnh mạch

Gạc vô khuẩn

Khẩu trang

Mũ phẫu thuật

5.4. Trang thiết bị

Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm bằng nhựa

Bộ đo CVP bằng cột nước được thiết kế phù hợp; không dùng hệ đo mở tự chế.

5.5. Người bệnh

Catheter trung tâm phù hợp đã được xác nhận vị trí, chọn nhánh đo an toàn; giải thích, đặt tư thế dung nạp, không ngắt máy thở và không tự ngừng thuốc vận mạch.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Y lệnh hoặc chỉ định hợp lệ, diễn biến, thông tin dị ứng và kết quả liên quan; phiếu chăm sóc hoặc theo dõi để ghi trước, trong và sau kỹ thuật.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Trung bình 05 phút - 15phút.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Phòng thực hiện kỹ thuật hoặc buồng bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh, chỉ định và kỹ thuật, dị ứng, kết quả liên quan, loại dụng cụ và tình trạng người bệnh; xác nhận đủ điều kiện trước thực hiện.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1: Định danh, kiểm tra chỉ định, vị trí catheter đã xác nhận và độ thông; xác định nhánh đo không làm gián đoạn thuốc thiết yếu. Vệ sinh tay, chuẩn bị hệ đo vô khuẩn đúng thiết kế.

6.2. Bước 2: Đặt tư thế dung nạp và giữ thống nhất khi so sánh. Chỉnh mốc 0 ngang mức tâm nhĩ phải, thường đường nách giữa ngang liên sườn 4 ở tư thế nằm phù hợp; ghi tư thế và góc đầu giường.

6.3. Bước 3: Kết nối thước cột nước và khóa theo hệ đo, dùng dịch đẳng trương được chỉ định, tránh khí lọt. Không dùng dịch pha vận mạch, không tháo dây ra khỏi chai để tự chế cột đo.

6.4. Bước 4: Thao tác khóa để nạp cột nước rồi thông cột với người bệnh đúng hướng dẫn. Đọc khi cột ổn định ở cuối thì thở ra; ghi đơn vị cmH2O, số đo, tư thế, mode thở và PEEP.

6.5. Bước 5: Không thấy dao động hoặc thấy dạng bất thường: kiểm tra hệ thống, dây và khóa, báo bác sĩ khi nghi catheter sai vị trí; không tự kéo catheter dựa vào dao động.

6.6. Bước 6: Kết thúc, khôi phục nhánh truyền theo chỉ định, đóng kín hệ đo, kiểm tra thông và thuốc đang truyền; ghi kết quả và diễn biến. Nếu không có bộ đo phù hợp, không dùng cách đo mở tự chế, báo để có phương tiện thay thế.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

Theo dõi toàn trạng, huyết động, dấu nhiễm khuẩn và độ thông catheter; chăm sóc băng theo quy trình CVC, không thay hằng ngày mặc định.

Tắc, di lệch hoặc nghi nhiễm khuẩn: ngừng sử dụng nhánh không an toàn, báo bác sĩ; không bơm cưỡng bức, tự rút hoặc đẩy catheter.

Nghi khí lọt, suy hô hấp hoặc huyết động xấu: gọi cấp cứu, xử trí theo tình trạng. Bác sĩ diễn giải CVP cùng các đánh giá khác, ưu tiên đánh giá đáp ứng dịch phù hợp, không theo trị số đơn độc.

Tài liệu đối chiếu

Nguồn chung và chuyên môn: [1], [2], [17], [13]. Hướng dẫn đúng loại vật tư và model thiết bị tại bệnh viện là tài liệu phải bổ sung khi phê duyệt.

Danh mục tài liệu đối chiếu

Nguồn kiểm tra ngày 13/10/2026. Tài liệu quốc tế dùng để đối chiếu các điểm an toàn và hỗ trợ thẩm định, không tự thay thế văn bản áp dụng tại Việt Nam. Bệnh viện đối chiếu bản chính thức và phạm vi kỹ thuật trước ban hành.

[1] QĐ 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 ban hành đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; dùng cho cấu trúc biên soạn, không thay thế hướng dẫn chuyên môn của từng kỹ thuật.

https://bvdkbaclieu.gov.vn/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-3023-qd-byt-cua-bo-y-te-ve-viec-ban-hanh-de-cu.html

[2] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956

[3] Thông tư 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=170581

[4] AARC 2022 Artificial Airway Suctioning. Đối chiếu kỹ thuật hút đường thở.

https://www.aarc.org/wp-content/uploads/2022/10/cpg-artificial-airway-suctioning.pdf

[5] AARC 2022 Management of Adult Patients With Oxygen in the Acute Care Setting.

https://www.aarc.org/wp-content/uploads/2022/10/cpg-clinical-mangement-adult-o2-acute-settings.pdf

[6] National Tracheostomy Safety Project và Tracoe Tracheostomy Learning Booklet.

https://tracheostomy.org.uk/storage/files/Tracoe%20tracheostomy%20learning%20booklet.pdf

[7] CDC Summary of Recommendations Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infections.

https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/cauti/summary-of-recommendations.html

[8] EAUN 2024 Indwelling Catheterisation in Adults. Thiết bị và bơm bóng catheter.

https://nurses.uroweb.org/guidelines/indwelling-catheterisation-in-adults-urethral-and-suprapubic/chapter/equipment-and-products

[9] CDC Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter Related Infections 2011 và trang khuyến cáo duy trì của CDC.

https://www.cdc.gov/infection-control/media/pdfs/Guideline-BSI-H.pdf

[10] NHS England Initial placement checks for nasogastric and orogastric tubes 2016 và enduring standards.

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2016/07/Resource_set_-_Initial_placement_checks_for_NG_tubes_1.pdf

[11] SCCM và ASPEN 2016 Guidelines for Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient.

https://sccmmedia.sccm.org/documents/LearnICU/Guidelines/Nutrition-SCCM-ASPEN.pdf

[12] CDC Infection Prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration.

https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/infection-control/

[13] Surviving Sepsis Campaign Adult Guidelines 2026. Đối chiếu việc dùng đánh giá huyết động động trong hồi sức dịch.

https://sccm.org/survivingsepsiscampaign/guidelines-and-resources/surviving-sepsis-campaign-adult-guidelines

[14] QĐ 3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1.

https://bvdkbaclieu.gov.vn/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-3375-qd-byt-2025-ve-viec-ban-hanh-tai-lieu-chuyen.html

[15] QĐ 3365/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Tiết niệu Tập 1.1.

https://benhvienquynhon.gov.vn/van-ban/van-ban-bo-y-te/quyet-dinh-so-3365-qd-byt-ve-viec-ban-hanh-tai-lieu-chuyen-mon-huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-ve-tiet-nieu-tap-1-1/

[16] QĐ 3676/QĐ-BYT ngày 28/11/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Tuần hoàn Tập 2.1; hiệu lực từ 01/7/2026.

https://syt.angiang.gov.vn/Lists/QuanLyVanBan/Attachments/8393/cv_tri%E1%BB%83n%20khai%20QTKT%20Tuan%20hoan%20%281%29.pdf

[17] QĐ 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức Cấp cứu và Chống độc; tài liệu nền trong bản nguồn, đối chiếu với hướng dẫn chuyên ngành mới và bằng chứng cập nhật.

Ghi nhận thẩm định và phê duyệt

Đơn vị thẩm định: …… Ngày: ……

Nội dung cần điều chỉnh sau thẩm định: ……

Danh mục model thiết bị và hướng dẫn đính kèm: ……

Xác nhận phạm vi, nhân sự, vật tư, thời gian, tần suất và các mục tiêu theo dõi: ……

Kết luận và số quyết định ban hành: ……

Người biên soạn	**Người thẩm định**	**Người phê duyệt**
Ký và ghi rõ họ tên	Ký và ghi rõ họ tên	Ký và ghi rõ họ tên